BỆNH VIỆN ĐA KHOA NHẬT TÂN

PHÒNG ĐIỀU DƯỠNG

QUY TRÌNH KỸ THUẬT ĐIỀU DƯỠNG CHUYÊN KHOA MẮT

Bản cập nhật ngày 13/10/2026 để trình thẩm định. Chưa phải văn bản đã ban hành.

Bộ gồm 17 quy trình thực có trong file nguồn; bỏ một dòng bơm rửa lệ đạo bị lặp trong mục lục. Giữ các bước phù hợp và chuyển đề cương theo QĐ3023. Mã M-01 đến M-17 là đề xuất.

Biên soạn: …… Thẩm định chuyên khoa: …… Phê duyệt: …… Số quyết định/ngày hiệu lực: ……

Nguyên tắc sử dụng

QĐ3023/QĐ-BYT ngày 28/7/2023 áp dụng cho đề cương và thể thức, không phải nguồn quy định mọi thao tác lâm sàng. Bản nguồn dẫn QĐ3517/QĐ-BYT; thông tin tra cứu xác định đây là tài liệu Mắt Tập 1 ngày 12/11/2025. Chưa có toàn bộ phụ lục kỹ thuật năm 2025 để kiểm tra từng thao tác, nên bộ này không tuyên bố đã đối chiếu đầy đủ QĐ3517. Khoa Mắt phải hoàn tất đối chiếu đúng mục kỹ thuật trước ban hành; không tự thay dẫn chiếu bằng QĐ3906 năm 2012.

Phạm vi thực hiện phải phù hợp danh mục kỹ thuật được phép, phạm vi hành nghề, năng lực và phân công có xác nhận. Thuốc, liều gây tê, thuốc giãn đồng tử, nồng độ sát khuẩn và cài đặt máy phải theo đúng nhãn/IFU và y lệnh. Không tự dùng danh mục vật tư như đơn thuốc hoặc mặc định điều dưỡng được thực hiện mọi thủ thuật xâm lấn.

Hỗ trợ ban đầu khi bỏng hóa chất: tưới rửa ngay bằng dung dịch phù hợp sẵn có và gọi bác sĩ theo quy trình cấp cứu mắt, không chờ đăng ký. Khi nghi nhãn cầu hở: tránh đè, đo nhãn áp, băng ép hoặc thao tác gây tăng áp lực; bảo vệ bằng che chắn phù hợp và chuyển bác sĩ Mắt khẩn. Nếu hai tình trạng có thể phối hợp, bác sĩ cấp cứu/Mắt đánh giá ngay và hướng dẫn xử trí an toàn.

Nguồn tham khảo an toàn: AAO EyeWiki, Pre-Ophthalmologist Management of Eye Trauma; https://eyewiki.aao.org/Pre-Ophthalmologist_Management_of_Eye_Trauma . AAO, Disinfection of Tonometers, https://www.aaojournal.org/article/S0161-6420%2817%2931677-9/fulltext . IFU của đúng nhãn áp kế là căn cứ chọn phương pháp tương thích; không áp quy trình đầu Goldmann cho mọi Schiotz.

Danh mục

M-01. QUY TRÌNH TIẾP NHẬN NGƯỜI BỆNH ĐẾN KHÁM MẮT
M-02. KỸ THUẬT ĐO THỊ LỰC
M-03. QUY TRÌNH KỸ THUẬT ĐO MÁY KHÚC XẠ
M-04. QUY TRÌNH BƠM RỬA LỆ ĐẠO
M-05. QUY TRÌNH BƠM THÔNG LỆ ĐẠO
M-06. QUY TRÌNH CHỤP ĐÁY MẮT
M-07. QUY TRÌNH RỬA – NHỎ MẮT – THAY BĂNG
M-08. QUY TRÌNH BÓC GIẢ MẠC
M-09. QUY TRÌNH LẤY SẠN VÔI
M-10. QUY TRÌNH NẶN TUYẾN BỜ MI
M-11. QUY TRÌNH NHỔ LÔNG XIÊU – ĐỐT LÔNG XIÊU
M-12. QUY TRÌNH CHÍCH CHẮP, LẸO
M-13. QUY TRÌNH CẮT CHỈ KHÂU KẾT MẠC
M-14. QUY TRÌNH ĐO NHÃN ÁP BẰNG NHÃN ÁP KẾ SCHIOTZ
M-15. QUY TRÌNH KỸ THUẬT PHỤ MỔ MỘNG THỊT
M-16. QUY TRÌNH KỸ THUẬT PHỤ MỔ QUẶM
M-17. QUY TRÌNH KỸ THUẬT PHỤ MỔ SỤP MI

M-01. QUY TRÌNH TIẾP NHẬN NGƯỜI BỆNH ĐẾN KHÁM MẮT

1. ĐẠI CƯƠNG

Tiếp nhận đúng người bệnh và thực hiện đầy đủ các bước tiếp nhận người bệnh.

2. CHỈ ĐỊNH

Các trường hợp đến khám mắt.

3. CHỐNG CHỈ ĐỊNH

Không có chống chỉ định tiếp nhận. Người không ngồi được, trẻ nhỏ hoặc không hợp tác được hỗ trợ bằng phương pháp phù hợp; người nguy kịch được nhận định và cấp cứu song song, không từ chối tiếp nhận.

4. THẬN TRỌNG

Xác định đúng người và mắt/bên; đánh giá dị ứng, thuốc và khả năng phối hợp. Đau tăng hoặc giảm thị lực cần bác sĩ đánh giá. Không để phép đo/thủ thuật trì hoãn cấp cứu; tránh ép nhãn cầu khi nghi vết thương hở. Trẻ em cần cách hỗ trợ và kế hoạch vô cảm phù hợp, không cố làm khi không an toàn.

5. CHUẨN BỊ

5.1. Người thực hiện

Người thực hiện: Điều dưỡng buồng khám Mắt.

Theo phạm vi hành nghề, năng lực và phân công đã được xác nhận. Bác sĩ xác lập chỉ định; điều dưỡng chuẩn bị, hỗ trợ và theo dõi, chỉ trực tiếp thực hiện thao tác thuộc phạm vi được giao.

5.2. Thuốc

Dùng theo y lệnh và đúng nhãn chế phẩm; xác nhận dị ứng, nồng độ, liều, đường dùng, mắt và hạn dùng/hạn sau mở. Không áp dụng thuốc khi kỹ thuật không cần; không dùng chế phẩm sát khuẩn da thay dung dịch dùng cho mắt.

5.3. Vật tư

Dụng cụ đo thị lực.

Gạc/tăm bông và dụng cụ tiếp xúc vết thương phải phù hợp vô khuẩn; vệ sinh tay, găng/bảo hộ theo nguy cơ. Mỗi mắt có vật tư làm sạch riêng; chuẩn bị hộp vật sắc nhọn khi liên quan.

5.4. Trang thiết bị

Máy đo huyết áp.

Kiểm tra hoạt động, hiệu chuẩn và IFU đúng model; khử khuẩn bề mặt dùng chung giữa người bệnh, xử lý dụng cụ tiếp xúc giác mạc theo quy trình đã xác nhận. Phương tiện cấp cứu sẵn tiếp cận.

5.5. Người bệnh

Được giải thích về kỹ thuật sắp được tiến hành.

Giải thích, xác nhận hợp tác/đồng ý theo mức can thiệp; đánh giá bệnh nền, thuốc, dị ứng và đúng mắt cần thực hiện.

5.6. Hồ sơ bệnh án

Theo quy định của Bộ y tế.

Có chỉ định, đánh giá và thông tin cần thiết của đúng người; giấy đồng ý và hồ sơ phẫu thuật khi áp dụng.

5.7. Thời gian thực hiện kỹ thuật

Thời gian thực hiện kỹ thuật: khoảng 3 – 10 phút.

Thời gian trong nguồn chỉ là ước tính, không phải thời gian bắt buộc chờ; ghi thực tế và theo dõi theo tình trạng.

5.8. Địa điểm thực hiện kỹ thuật

Địa điểm thực hiện kỹ thuật: phòng tiếp nhận bệnh.

5.9. Kiểm tra hồ sơ và người bệnh

Đối chiếu ít nhất hai định danh và đúng mắt/bên; kiểm tra chỉ định, nguy cơ, thuốc, dụng cụ, thiết bị, đồng ý và nhân lực. Dừng khi sai hoặc thiếu điều kiện, báo bác sĩ giải quyết.

6. TIẾN HÀNH QUY TRÌNH KỸ THUẬT

6.1. Xác nhận và chuẩn bị thao tác

Thực hiện kiểm tra mục 5.9, vệ sinh tay và bố trí người bệnh; các bước dưới đây thực hiện bởi người đủ phạm vi và năng lực theo phân công.

6.2. Thực hiện kỹ thuật

Điều dưỡng tiếp nhận sổ khám bệnh;

Đối chiếu đúng thông tin người bệnh;

Sàng lọc ngay dấu hiệu cấp cứu toàn thân và mắt: giảm thị lực đột ngột, đau mắt dữ dội, chấn thương, nghi vết thương hở nhãn cầu hoặc bỏng hóa chất. Báo bác sĩ, hỗ trợ/chuyển cấp cứu theo tình trạng; không chờ đăng ký, đo thị lực đầy đủ hoặc thanh toán.

Nhận định tình trạng người bệnh;

Đo thị lực;

Lấy dấu hiệu sinh tồn (Mạch, nhiệt độ, huyết áp, nhịp thở);

Khai thác tiền sử bệnh, tiền sử dị ứng thuốc;

Báo bác sĩ những dấu hiệu bất thường (nếu có).

Ghi thông tin vào sổ khám bệnh;

Sát khuẩn tay nhanh;

Mời bác sĩ khám bệnh;

Ghi nhận chỉ định đã được bác sĩ xác lập vào đúng hồ sơ theo phân quyền; không tự chỉ định thuốc, cận lâm sàng hoặc thủ thuật.

Thực hiện kỹ thuật trong phạm vi được giao khi có chỉ định và đủ điều kiện; kỹ thuật xâm lấn cần người thực hiện có phạm vi hành nghề và năng lực đã xác nhận.

Hoàn tất thủ tục khám bệnh và in mẫu thanh toán 01 cho bệnh nhân.

Hướng dẫn bệnh nhân thanh toán tại quầy viện phí, và quay lại phòng khám để nhận sổ khám bệnh;

Tư vấn, giáo dục sức khỏe cho bệnh nhân;

Hướng dẫn bệnh nhân lãnh thuốc tại khoa dược.;

Hướng dẫn bệnh nhân uống thuốc theo toa và tái khám khi có lịch hẹn.

6.3. Kết thúc và bàn giao

Đánh giá mắt và tình trạng người bệnh, ghi kết quả/thuốc/thao tác, diễn biến, giờ và người thực hiện; báo bác sĩ bất thường. Thu dọn, xử lý dụng cụ và chất thải đúng quy định; hướng dẫn chăm sóc và lịch khám, bàn giao khi chuyển.

7. THEO DÕI VÀ XỬ TRÍ TAI BIẾN

7.1. Trong thực hiện

Khi sai người/mắt, phản ứng thuốc, đau dữ dội, tổn thương hoặc diễn biến toàn thân bất thường: dừng, bảo đảm an toàn, báo bác sĩ, đánh giá và xử trí theo tình trạng. Phản vệ xử trí ngay theo Thông tư 51/2017/TT-BYT; không trì hoãn cấp cứu để hoàn tất hồ sơ.

7.2. Sau thực hiện

Theo dõi đau, đỏ mắt, chảy máu và thị lực theo kỹ thuật. Giảm thị lực, đau tăng, sợ sáng hoặc khó chịu kéo dài cần bác sĩ khám. Không chỉ băng mắt hoặc tự cho thuốc để thay khám nguyên nhân. Thuốc và băng theo y lệnh.

7.3. Theo dõi muộn

Hướng dẫn không dụi mắt, dùng thuốc đúng đơn và tái khám theo chỉ định; quay lại ngay khi đau tăng, nhìn mờ hoặc triệu chứng xấu đi. Ghi và báo cáo sự cố, đánh giá lại trước thực hiện tiếp; không khẳng định tuyệt đối “không tai biến”.

Tài liệu tham khảo

QĐ3023/QĐ-BYT ngày 28/7/2023 về đề cương. Tài liệu nguồn QTKT DD năm 2025 do bệnh viện cung cấp. QĐ3517/QĐ-BYT ngày 12/11/2025 về Mắt Tập 1: cần đối chiếu đầy đủ đúng mục kỹ thuật trước ban hành. IFU và nhãn thuốc thực tế phải được xác nhận; các nguồn an toàn tại phần đầu hỗ trợ rà soát, không thay thế chỉ định chuyên khoa.

Danh mục chuẩn bị của kỹ thuật

TT	Danh mục chuẩn bị	Đơn vị	Số lượng
1	Lao động trực tiếp		

TT	Danh mục chuẩn bị	Đơn vị	Số lượng
1.1	Điều dưỡng	Người	01
2	Thuốc (tên hoạt chất, nồng độ, hàm lượng, đường dùng/dạng dùng)		Theo y lệnh / nhãn
2.1			
3	Vật tư (được sử dụng trực tiếp)		
3.1			
3.2			
3.3			
4	Trang thiết bị (sử dụng trực tiếp)		
4.1	Che mắt	Cái	01
4.2	Bảng đo thị lực	Cái	01
	Máy đo huyết áp	Cái	01

Danh mục kế thừa từ nguồn để đối chiếu, phải điều chỉnh đúng thiết bị và chỉ định; không thay thế các điều kiện mục 5. Thuốc/thiết bị có thông tin chưa xác nhận thì chưa sử dụng.

M-02. KỸ THUẬT ĐO THỊ LỰC

1. ĐẠI CƯƠNG

Đánh giá khả năng nhìn chi tiết của mắt, để theo dõi, chẩn đoán và điều trị các bệnh về mắt.

2. CHỈ ĐỊNH

Các trường hợp đến khám mắt

3. CHỐNG CHỈ ĐỊNH

Không có chống chỉ định tuyệt đối của đánh giá thị lực không tiếp xúc. Tư thế và bảng thử cần điều chỉnh cho người không ngồi được, trẻ nhỏ hoặc khó phối hợp; không trì hoãn cấp cứu để đo đủ.

4. THẬN TRỌNG

Xác định đúng người và mắt/bên; đánh giá dị ứng, thuốc và khả năng phối hợp. Đau tăng hoặc giảm thị lực cần bác sĩ đánh giá. Không để phép đo/thủ thuật trì hoãn cấp cứu; tránh ép nhãn cầu khi nghi vết thương hở. Trẻ em cần cách hỗ trợ và kế hoạch vô cảm phù hợp, không cố làm khi không an toàn.

5. CHUẨN BỊ

5.1. Người thực hiện

Người thực hiện: Điều dưỡng buồng khám Mắt.

Theo phạm vi hành nghề, năng lực và phân công đã được xác nhận. Bác sĩ xác lập chỉ định; điều dưỡng chuẩn bị, hỗ trợ và theo dõi, chỉ trực tiếp thực hiện thao tác thuộc phạm vi được giao.

5.2. Thuốc

Dùng theo y lệnh và đúng nhãn chế phẩm; xác nhận dị ứng, nồng độ, liều, đường dùng, mắt và hạn dùng/hạn sau mở. Không áp dụng thuốc khi kỹ thuật không cần; không dùng chế phẩm sát khuẩn da thay dung dịch dùng cho mắt.

5.3. Vật tư

Gạc/tăm bông và dụng cụ tiếp xúc vết thương phải phù hợp vô khuẩn; vệ sinh tay, găng/bảo hộ theo nguy cơ. Mỗi mắt có vật tư làm sạch riêng; chuẩn bị hộp vật sắc nhọn khi liên quan.

5.4. Trang thiết bị

Bảng đo thị lực, dụng cụ che mắt.

Kiểm tra hoạt động, hiệu chuẩn và IFU đúng model; khử khuẩn bề mặt dùng chung giữa người bệnh, xử lý dụng cụ tiếp xúc giác mạc theo quy trình đã xác nhận. Phương tiện cấp cứu sẵn tiếp cận.

5.5. Người bệnh

Báo và giải thích cho bệnh nhân kỹ thuật sắp làm.

Giải thích, xác nhận hợp tác/đồng ý theo mức can thiệp; đánh giá bệnh nền, thuốc, dị ứng và đúng mắt cần thực hiện.

5.6. Hồ sơ bệnh án

Theo quy định của Bộ y tế.

Có chỉ định, đánh giá và thông tin cần thiết của đúng người; giấy đồng ý và hồ sơ phẫu thuật khi áp dụng.

5.7. Thời gian thực hiện kỹ thuật

Thời gian thực hiện kỹ thuật: khoảng 3 – 5 phút.

Thời gian trong nguồn chỉ là ước tính, không phải thời gian bắt buộc chờ; ghi thực tế và theo dõi theo tình trạng.

5.8. Địa điểm thực hiện kỹ thuật

Địa điểm thực hiện kỹ thuật: phòng tiếp nhận bệnh.

5.9. Kiểm tra hồ sơ và người bệnh

Đối chiếu ít nhất hai định danh và đúng mắt/bên; kiểm tra chỉ định, nguy cơ, thuốc, dụng cụ, thiết bị, đồng ý và nhân lực. Dừng khi sai hoặc thiếu điều kiện, báo bác sĩ giải quyết.

6. TIẾN HÀNH QUY TRÌNH KỸ THUẬT

6.1. Xác nhận và chuẩn bị thao tác

Thực hiện kiểm tra mục 5.9, vệ sinh tay và bố trí người bệnh; các bước dưới đây thực hiện bởi người đủ phạm vi và năng lực theo phân công.

6.2. Thực hiện kỹ thuật

Kiểm tra đúng thông tin người bệnh.

Báo và giải thích cho bệnh nhân kỹ thuật sắp làm.

Hướng dẫn bệnh nhân những điều cần thiết.

- Điều dưỡng rửa tay, mang khẩu trang
- Hướng dẫn cho bệnh nhân cách đo thị lực

Đặt khoảng cách đo đúng loại bảng/máy đã được hiệu chuẩn; chỉ dùng 5 m nếu bảng được thiết kế cho 5 m. Bảo đảm ánh sáng theo hướng dẫn bảng.

Che mắt không được đo bằng dụng cụ sạch, không đè lên nhãn cầu và không để người bệnh nhìn lén.

- Đo thị lực từng mắt (để không ghi nhầm chỉ số thị lực, nên đo mắt phải trước, sau đó đo mắt trái)

Đo từng mắt, từ ký hiệu lớn đến nhỏ theo hướng dẫn bảng; ghi dòng đọc được và tiêu chí chấm đúng loại bảng, không mặc định mỗi dòng lần lượt 1/10, 2/10 cho mọi bảng. Ghi thị lực không kính/có kính đang dùng; thử kính lỗ khi được chỉ định.

Nếu không đọc được dòng lớn nhất, thử đếm ngón tay ở khoảng cách xác định rồi điều chỉnh gần hơn; ghi đúng khoảng cách thực đo và mắt. Không chạm mắt.

- Đo thị lực bằng bóng bàn tay: Nếu đếm không đúng với khoảng cách 0,5m thì ta thử bằng cách vẫy tay trước mặt bệnh nhân khoảng cách gần nhất hỏi bệnh nhân thấy bàn tay vẫy trước mặt không? Trả lời đúng ta ghi kết quả (Ví dụ: MP: BBT)

Nếu không nhận biết bóng bàn tay, thử cảm giác sáng tối từng mắt, tránh ánh sáng lọt sang mắt che; ghi ST (+) hoặc ST (−) theo đáp ứng đáng tin cậy. Khi không đủ khả năng phối hợp, ghi không đánh giá được và báo bác sĩ, không mặc định ST (−).

- Ghi hồ sơ

+ Ngày giờ đo thị lực, kết quả thị lực.

+ Người thực hiện.

Thu dọnn dụng cụ

6.3. Kết thúc và bàn giao

Đánh giá mắt và tình trạng người bệnh, ghi kết quả/thuốc/thao tác, diễn biến, giờ và người thực hiện; báo bác sĩ bất thường. Thu dọn, xử lý dụng cụ và chất thải đúng quy định; hướng dẫn chăm sóc và lịch khám, bàn giao khi chuyển.

7. THEO DÕI VÀ XỬ TRÍ TAI BIẾN

7.1. Trong thực hiện

Khi sai người/mắt, phản ứng thuốc, đau dữ dội, tổn thương hoặc diễn biến toàn thân bất thường: dừng, bảo đảm an toàn, báo bác sĩ, đánh giá và xử trí theo tình trạng. Phản vệ xử trí ngay theo Thông tư 51/2017/TT-BYT; không trì hoãn cấp cứu để hoàn tất hồ sơ.

7.2. Sau thực hiện

Theo dõi đau, đỏ mắt, chảy máu và thị lực theo kỹ thuật. Giảm thị lực, đau tăng, sợ sáng hoặc khó chịu kéo dài cần bác sĩ khám. Không chỉ băng mắt hoặc tự cho thuốc để thay khám nguyên nhân. Thuốc và băng theo y lệnh.

7.3. Theo dõi muộn

Hướng dẫn không dụi mắt, dùng thuốc đúng đơn và tái khám theo chỉ định; quay lại ngay khi đau tăng, nhìn mờ hoặc triệu chứng xấu đi. Ghi và báo cáo sự cố, đánh giá lại trước thực hiện tiếp; không khẳng định tuyệt đối “không tai biến”.

Tài liệu tham khảo

QĐ3023/QĐ-BYT ngày 28/7/2023 về đề cương. Tài liệu nguồn QTKT DD năm 2025 do bệnh viện cung cấp. QĐ3517/QĐ-BYT ngày 12/11/2025 về Mắt Tập 1: cần đối chiếu đầy đủ đúng mục kỹ thuật trước ban hành. IFU và nhãn thuốc thực tế phải được xác nhận; các nguồn an toàn tại phần đầu hỗ trợ rà soát, không thay thế chỉ định chuyên khoa.

Danh mục chuẩn bị của kỹ thuật

TT	Danh mục chuẩn bị	Đơn vị	Số lượng
1	Lao động trực tiếp		

TT	Danh mục chuẩn bị	Đơn vị	Số lượng
1.1	Điều dưỡng	Người	01
2	Thuốc (tên hoạt chất, nồng độ, hàm lượng, đường dùng/dạng dùng)		Theo y lệnh / nhãn
2.1			
3	Vật tư (được sử dụng trực tiếp)		
3.1			
3.2			
3.3			
4	Trang thiết bị (sử dụng trực tiếp)		
4.1	Che mắt	Cái	01
4.2	Bảng đo thị lực	Cái	01

Danh mục kế thừa từ nguồn để đối chiếu, phải điều chỉnh đúng thiết bị và chỉ định; không thay thế các điều kiện mục 5. Thuốc/thiết bị có thông tin chưa xác nhận thì chưa sử dụng.

M-03. QUY TRÌNH KỸ THUẬT ĐO MÁY KHÚC XẠ

1. ĐẠI CƯƠNG

Là phương pháp đánh giá khúc xạ khách quan dựa vào máy khúc xạ kế tự động

2. CHỈ ĐỊNH

Các trường hợp cần xác định tình trạng khúc xạ của mắt.

3. CHỐNG CHỈ ĐỊNH

Bác sĩ đánh giá trường hợp có bệnh mắt cấp; không thực hiện nếu đo làm trì hoãn xử trí hoặc thiết bị/tư thế không bảo đảm an toàn.

Trẻ nhỏ, người cao tuổi hoặc khó phối hợp: lựa chọn máy/phương pháp phù hợp, ghi giới hạn chất lượng; tuổi tự nó không phải chống chỉ định tuyệt đối.

Người không ngồi được hoặc tình trạng toàn thân không ổn định: báo bác sĩ lựa chọn phương pháp khác hoặc hoãn phép đo, tiếp tục chăm sóc cần thiết.

4. THẬN TRỌNG

Xác định đúng người và mắt/bên; đánh giá dị ứng, thuốc và khả năng phối hợp. Đau tăng hoặc giảm thị lực cần bác sĩ đánh giá. Không để phép đo/thủ thuật trì hoãn cấp cứu; tránh ép nhãn cầu khi nghi vết thương hở. Trẻ em cần cách hỗ trợ và kế hoạch vô cảm phù hợp, không cố làm khi không an toàn.

5. CHUẨN BỊ

5.1. Người thực hiện

Người thực hiện: Kỹ thuật viên khúc xạ hoặc điều dưỡng chuyên khoa Mắt.

Theo phạm vi hành nghề, năng lực và phân công đã được xác nhận. Bác sĩ xác lập chỉ định; điều dưỡng chuẩn bị, hỗ trợ và theo dõi, chỉ trực tiếp thực hiện thao tác thuộc phạm vi được giao.

5.2. Thuốc

Dùng theo y lệnh và đúng nhãn chế phẩm; xác nhận dị ứng, nồng độ, liều, đường dùng, mắt và hạn dùng/hạn sau mở. Không áp dụng thuốc khi kỹ thuật không cần; không dùng chế phẩm sát khuẩn da thay dung dịch dùng cho mắt.

5.3. Vật tư

Gạc/tăm bông và dụng cụ tiếp xúc vết thương phải phù hợp vô khuẩn; vệ sinh tay, găng/bảo hộ theo nguy cơ. Mỗi mắt có vật tư làm sạch riêng; chuẩn bị hộp vật sắc nhọn khi liên quan.

5.4. Trang thiết bị

Máy đo khúc xạ tự động.

Kiểm tra hoạt động, hiệu chuẩn và IFU đúng model; khử khuẩn bề mặt dùng chung giữa người bệnh, xử lý dụng cụ tiếp xúc giác mạc theo quy trình đã xác nhận. Phương tiện cấp cứu sẵn tiếp cận.

5.5. Người bệnh

Được giải thích về kỹ thuật sắp được tiến hành.

Giải thích, xác nhận hợp tác/đồng ý theo mức can thiệp; đánh giá bệnh nền, thuốc, dị ứng và đúng mắt cần thực hiện.

5.6. Hồ sơ bệnh án

Theo quy định của Bộ y tế.

Có chỉ định, đánh giá và thông tin cần thiết của đúng người; giấy đồng ý và hồ sơ phẫu thuật khi áp dụng.

5.7. Thời gian thực hiện kỹ thuật

Thời gian thực hiện kỹ thuật: khoảng 3 – 5 phút.

Thời gian trong nguồn chỉ là ước tính, không phải thời gian bắt buộc chờ; ghi thực tế và theo dõi theo tình trạng.

5.8. Địa điểm thực hiện kỹ thuật

Địa điểm thực hiện kỹ thuật: phòng đo khúc xạ.

5.9. Kiểm tra hồ sơ và người bệnh

Đối chiếu ít nhất hai định danh và đúng mắt/bên; kiểm tra chỉ định, nguy cơ, thuốc, dụng cụ, thiết bị, đồng ý và nhân lực. Dừng khi sai hoặc thiếu điều kiện, báo bác sĩ giải quyết.

6. TIẾN HÀNH QUY TRÌNH KỸ THUẬT

6.1. Xác nhận và chuẩn bị thao tác

Thực hiện kiểm tra mục 5.9, vệ sinh tay và bố trí người bệnh; các bước dưới đây thực hiện bởi người đủ phạm vi và năng lực theo phân công.

6.2. Thực hiện kỹ thuật

Xác nhận hai định danh, mắt đo và chỉ định; vệ sinh tay, kiểm tra máy và bề mặt tì trán/cằm.

Báo và giải thích cho bệnh nhân kỹ thuật sắp làm

Hướng dẫn bệnh nhân những điều cần thiết.

Điều dưỡng rửa tay, mang khẩu trang

Bật công tác máy, lưu ý không để cằm người bệnh trong lúc khởi động máy..

Kiểm tra và chọn chế độ trên màn hình LCD, chọn AUTO

Yêu cầu người bệnh đặt cằm vào giá đỡ, trán áp sát vào băng tì trán.

Kiểm tra để đảm bảo mắt người bệnh ngang vị trí đánh dấu trên giá cố định đầu.

Yêu cầu bệnh nhân nhìn thẳng vào ống kính của máy đo, nhìn vào vật trong ống kính máy đo (thường hình ngôi nhà, hình khinh khí cầu….) khúc xạ.

Căn chỉnh, lấy số lần đo và kiểm tra độ tin cậy theo đúng model và hướng dẫn sử dụng; không áp dụng màu báo hoặc ba lần đo của một máy cho mọi máy.

Di chuyển qua mắt còn lại và làm như các bước trên.

Ghi từng mắt: cầu, trụ, trục và chỉ số liên quan của máy; lưu chất lượng và điều kiện đo. Kết quả tự động cần bác sĩ/chuyên viên đánh giá cùng khám khúc xạ, không tự chuyển thành đơn kính.

Tắt công tắc ON/OFF để tắt máy và cố định máy.

6.3. Kết thúc và bàn giao

Đánh giá mắt và tình trạng người bệnh, ghi kết quả/thuốc/thao tác, diễn biến, giờ và người thực hiện; báo bác sĩ bất thường. Thu dọn, xử lý dụng cụ và chất thải đúng quy định; hướng dẫn chăm sóc và lịch khám, bàn giao khi chuyển.

7. THEO DÕI VÀ XỬ TRÍ TAI BIẾN

7.1. Trong thực hiện

Nhầm lẫn người bệnh, nhầm mắt đo.

Khi sai người/mắt, phản ứng thuốc, đau dữ dội, tổn thương hoặc diễn biến toàn thân bất thường: dừng, bảo đảm an toàn, báo bác sĩ, đánh giá và xử trí theo tình trạng. Phản vệ xử trí ngay theo Thông tư 51/2017/TT-BYT; không trì hoãn cấp cứu để hoàn tất hồ sơ.

7.2. Sau thực hiện

Theo dõi đau, đỏ mắt, chảy máu và thị lực theo kỹ thuật. Giảm thị lực, đau tăng, sợ sáng hoặc khó chịu kéo dài cần bác sĩ khám. Không chỉ băng mắt hoặc tự cho thuốc để thay khám nguyên nhân. Thuốc và băng theo y lệnh.

7.3. Theo dõi muộn

Hướng dẫn không dụi mắt, dùng thuốc đúng đơn và tái khám theo chỉ định; quay lại ngay khi đau tăng, nhìn mờ hoặc triệu chứng xấu đi. Ghi và báo cáo sự cố, đánh giá lại trước thực hiện tiếp; không khẳng định tuyệt đối “không tai biến”.

Tài liệu tham khảo

QĐ3023/QĐ-BYT ngày 28/7/2023 về đề cương. Tài liệu nguồn QTKT DD năm 2025 do bệnh viện cung cấp. QĐ3517/QĐ-BYT ngày 12/11/2025 về Mắt Tập 1: cần đối chiếu đầy đủ đúng mục kỹ thuật trước ban hành. IFU và nhãn thuốc thực tế phải được xác nhận; các nguồn an toàn tại phần đầu hỗ trợ rà soát, không thay thế chỉ định chuyên khoa.

Danh mục chuẩn bị của kỹ thuật

TT	Danh mục chuẩn bị	Đơn vị	Số lượng
1	Lao động trực tiếp		
1.1	Kỹ thuật viên khúc xạ hoặc điều dưỡng chuyên khoa Mắt	Người	01
2	Thuốc (tên hoạt chất, nồng độ, hàm lượng, đường dùng/dạng dùng)		Theo y lệnh / nhãn

TT	Danh mục chuẩn bị	Đơn vị	Số lượng
2.1			
3	Vật tư (được sử dụng trực tiếp)		
3.1			
3.2			
3.3			
4	Trang thiết bị (sử dụng trực tiếp)		
4.1	Máy đo khúc xạ tự động	Cái	01
4.2			

Danh mục kế thừa từ nguồn để đối chiếu, phải điều chỉnh đúng thiết bị và chỉ định; không thay thế các điều kiện mục 5. Thuốc/thiết bị có thông tin chưa xác nhận thì chưa sử dụng.

M-04. QUY TRÌNH BƠM RỬA LỆ ĐẠO

1. ĐẠI CƯƠNG

Bơm rửa lệ đạo là kỹ thuật làm sạch đường dẫn lệ, kiểm tra sự lưu thông.

2. CHỈ ĐỊNH

Chuẩn bị trước các phẫu thuật có can thiệp vào nội nhãn như đục thủy tinh thể, glaucoma.

Một số trường hợp viêm loét giác mạc.

Các trường hợp nghi ngờ tắc hẹp lệ đạo.

Trước khi tiến hành thông lệ đạo.

3. CHỐNG CHỈ ĐỊNH

Áp xe túi lệ.

4. THẬN TRỌNG

Xác định đúng người và mắt/bên; đánh giá dị ứng, thuốc và khả năng phối hợp. Đau tăng hoặc giảm thị lực cần bác sĩ đánh giá. Không để phép đo/thủ thuật trì hoãn cấp cứu; tránh ép nhãn cầu khi nghi vết thương hở. Trẻ em cần cách hỗ trợ và kế hoạch vô cảm phù hợp, không cố làm khi không an toàn.

Kỹ thuật có tiếp xúc mắt hoặc xâm lấn: xác nhận năng lực, dùng dụng cụ được xử lý đúng và bảo vệ giác mạc. Không cố đưa dụng cụ qua cản trở; nếu đau/chảy máu bất thường phải dừng.

5. CHUẨN BỊ

5.1. Người thực hiện

Người thực hiện được phân công, có phạm vi và năng lực bơm rửa lệ đạo đã xác nhận; bác sĩ Mắt chỉ định, giám sát/hỗ trợ theo tổ chức đơn vị.

Theo phạm vi hành nghề, năng lực và phân công đã được xác nhận. Bác sĩ xác lập chỉ định; điều dưỡng chuẩn bị, hỗ trợ và theo dõi, chỉ trực tiếp thực hiện thao tác thuộc phạm vi được giao.

5.2. Thuốc

Thuốc tê Alcain 0.5%.

Dùng theo y lệnh và đúng nhãn chế phẩm; xác nhận dị ứng, nồng độ, liều, đường dùng, mắt và hạn dùng/hạn sau mở. Không áp dụng thuốc khi kỹ thuật không cần; không dùng chế phẩm sát khuẩn da thay dung dịch dùng cho mắt.

5.3. Vật tư

Que nông điểm lệ.

Bộ que thông lệ đạo với các cơ số khác nhau.

Dung dịch nước muối sinh lý 0.9%.

Bơm tiêm 5ml.

Gạc/tăm bông và dụng cụ tiếp xúc vết thương phải phù hợp vô khuẩn; vệ sinh tay, găng/bảo hộ theo nguy cơ. Mỗi mắt có vật tư làm sạch riêng; chuẩn bị hộp vật sắc nhọn khi liên quan.

5.4. Trang thiết bị

Kiểm tra hoạt động, hiệu chuẩn và IFU đúng model; khử khuẩn bề mặt dùng chung giữa người bệnh, xử lý dụng cụ tiếp xúc giác mạc theo quy trình đã xác nhận. Phương tiện cấp cứu sẵn tiếp cận.

5.5. Người bệnh

Được giải thích về mục đích và các thì của thủ thuật. Nếu là trẻ em, cần giải thích cho người nhà để phối hợp.

Giải thích, xác nhận hợp tác/đồng ý theo mức can thiệp; đánh giá bệnh nền, thuốc, dị ứng và đúng mắt cần thực hiện.

5.6. Hồ sơ bệnh án

Theo quy định của Bộ y tế.

Có chỉ định, đánh giá và thông tin cần thiết của đúng người; giấy đồng ý và hồ sơ phẫu thuật khi áp dụng.

5.7. Thời gian thực hiện kỹ thuật

Thời gian thực hiện kỹ thuật: khoảng 3 – 7 phút.

Thời gian trong nguồn chỉ là ước tính, không phải thời gian bắt buộc chờ; ghi thực tế và theo dõi theo tình trạng.

5.8. Địa điểm thực hiện kỹ thuật

Địa điểm thực hiện kỹ thuật: phòng thủ thuật.

5.9. Kiểm tra hồ sơ và người bệnh

Đối chiếu ít nhất hai định danh và đúng mắt/bên; kiểm tra chỉ định, nguy cơ, thuốc, dụng cụ, thiết bị, đồng ý và nhân lực. Dừng khi sai hoặc thiếu điều kiện, báo bác sĩ giải quyết.

6. TIẾN HÀNH QUY TRÌNH KỸ THUẬT

6.1. Xác nhận và chuẩn bị thao tác

Thực hiện kiểm tra mục 5.9, vệ sinh tay và bố trí người bệnh; các bước dưới đây thực hiện bởi người đủ phạm vi và năng lực theo phân công.

6.2. Thực hiện kỹ thuật

Hướng dẫn bệnh nhân nằm ngửa đầu bằng hoặc kê gối thấp.

Điều dưỡng ngồi ở phía đỉnh đầu bệnh nhân.

Rửa sạch mắt bệnh nhân.

Nhỏ thuốc tê bề mặt đúng chế phẩm, liều và thời điểm theo y lệnh/nhãn; kiểm tra dị ứng. Không mặc định một lịch nhỏ lặp cho mọi người bệnh.

Vệ sinh tay, mang bảo hộ và găng phù hợp; dụng cụ đi vào lệ đạo phải vô khuẩn, dung dịch và đầu bơm tương thích dùng đúng mục đích.

Chuẩn bị dung dịch bơm rửa theo chỉ định, gắn chắc cannula đầu tù phù hợp; không dùng kim sắc thay cannula lệ đạo.

Thử kim

Dùng ngón tay trái kéo nhẹ da mi bệnh nhân xuống dưới ra ngoài để cố định mi và điểm lệ

Người được phép thực hiện đưa cannula qua điểm lệ vào lệ quản theo giải phẫu, thao tác nhẹ; không dùng lực khi gặp cản trở, không áp dụng độ sâu cố định cho mọi tuổi.

Bơm nhẹ, theo dõi đau, trào dịch, khả năng lưu thông và phản ứng hô hấp; dừng khi đau nhiều, phù, nghi sai đường hoặc sặc.

Đánh giá kết quả sau khi bơm rửa lệ đạo

Rửa mắt cho bệnh nhân, cho bệnh nhân ngồi dậy.

Ghi hồ sơ

Thu dọn dụng cụ, rửa tay

Khi sặc: dừng bơm, đánh giá đường thở và hô hấp, gọi hỗ trợ, hút dịch khi phù hợp. Chỉ áp dụng thủ thuật giải phóng tắc nghẽn khi có dấu hiệu tắc đường thở theo hướng dẫn phù hợp tuổi; không vỗ lưng mặc định mọi trường hợp.

Trẻ đang bị viêm đường hô hấp trên thì không nên làm thủ thuật này

6.3. Kết thúc và bàn giao

Đánh giá mắt và tình trạng người bệnh, ghi kết quả/thuốc/thao tác, diễn biến, giờ và người thực hiện; báo bác sĩ bất thường. Thu dọn, xử lý dụng cụ và chất thải đúng quy định; hướng dẫn chăm sóc và lịch khám, bàn giao khi chuyển.

7. THEO DÕI VÀ XỬ TRÍ TAI BIẾN

7.1. Trong thực hiện

Nghi nhiễm khuẩn, chảy máu, đau hoặc phù: dừng khi đang làm, báo bác sĩ khám và xử trí theo mức độ. Không tự dùng kháng sinh toàn thân hoặc chỉ băng rồi theo dõi khi chưa đánh giá.

Khi sai người/mắt, phản ứng thuốc, đau dữ dội, tổn thương hoặc diễn biến toàn thân bất thường: dừng, bảo đảm an toàn, báo bác sĩ, đánh giá và xử trí theo tình trạng. Phản vệ xử trí ngay theo Thông tư 51/2017/TT-BYT; không trì hoãn cấp cứu để hoàn tất hồ sơ.

7.2. Sau thực hiện

Theo dõi đau, đỏ mắt, chảy máu và thị lực theo kỹ thuật. Giảm thị lực, đau tăng, sợ sáng hoặc khó chịu kéo dài cần bác sĩ khám. Không chỉ băng mắt hoặc tự cho thuốc để thay khám nguyên nhân. Thuốc và băng theo y lệnh.

7.3. Theo dõi muộn

Hướng dẫn không dụi mắt, dùng thuốc đúng đơn và tái khám theo chỉ định; quay lại ngay khi đau tăng, nhìn mờ hoặc triệu chứng xấu đi. Ghi và báo cáo sự cố, đánh giá lại trước thực hiện tiếp; không khẳng định tuyệt đối “không tai biến”.

Tài liệu tham khảo

QĐ3023/QĐ-BYT ngày 28/7/2023 về đề cương. Tài liệu nguồn QTKT DD năm 2025 do bệnh viện cung cấp. QĐ3517/QĐ-BYT ngày 12/11/2025 về Mắt Tập 1: cần đối chiếu đầy đủ đúng mục kỹ thuật trước ban hành. IFU và nhãn thuốc thực tế phải được xác nhận; các nguồn an toàn tại phần đầu hỗ trợ rà soát, không thay thế chỉ định chuyên khoa.

Danh mục chuẩn bị của kỹ thuật

TT	Danh mục chuẩn bị	Đơn vị	Số lượng
1	Lao động trực tiếp		
1.1	Điều dưỡng chuyên khoa Mắt	Người	01
2	Thuốc (tên hoạt chất, nồng độ, hàm lượng, đường dùng/dạng dùng)		Theo y lệnh / nhãn
2.1	Nước muối sinh lý 0.9%	Chai	01
2.2	Alcain 0.5%	Chai	Theo y lệnh / nhãn
3	Vật tư (được sử dụng trực tiếp)		
3.1	Bơm tiêm 5ml	Cái	01
3.2	Kim đầu tù	Cái	01
3.3	Khẩu trang, gang tay sạch	Cái	01
4	Trang thiết bị (sử dụng trực tiếp)		
4.1	Đèn phẫu thuật		

Danh mục kế thừa từ nguồn để đối chiếu, phải điều chỉnh đúng thiết bị và chỉ định; không thay thế các điều kiện mục 5. Thuốc/thiết bị có thông tin chưa xác nhận thì chưa sử dụng.

M-05. QUY TRÌNH BƠM THÔNG LỆ ĐẠO

1. ĐẠI CƯƠNG

Bơm rửa lệ đạo là kỹ thuật làm sạch đường dẫn lệ, kiểm tra sự lưu thông và làm thông đường dẫn lệ.

2. CHỈ ĐỊNH

Tắc lệ đạo được bác sĩ xác định có chỉ định thông; chảy nước mắt đơn thuần chưa đủ để quyết định thủ thuật.

3. CHỐNG CHỈ ĐỊNH

Áp xe túi lệ.

4. THẬN TRỌNG

Xác định đúng người và mắt/bên; đánh giá dị ứng, thuốc và khả năng phối hợp. Đau tăng hoặc giảm thị lực cần bác sĩ đánh giá. Không để phép đo/thủ thuật trì hoãn cấp cứu; tránh ép nhãn cầu khi nghi vết thương hở. Trẻ em cần cách hỗ trợ và kế hoạch vô cảm phù hợp, không cố làm khi không an toàn.

Kỹ thuật có tiếp xúc mắt hoặc xâm lấn: xác nhận năng lực, dùng dụng cụ được xử lý đúng và bảo vệ giác mạc. Không cố đưa dụng cụ qua cản trở; nếu đau/chảy máu bất thường phải dừng.

5. CHUẨN BỊ

5.1. Người thực hiện

Bác sĩ Mắt hoặc người hành nghề được phép, đã được xác nhận năng lực thực hiện thông lệ đạo; điều dưỡng chuẩn bị, hỗ trợ và theo dõi theo phân công.

Theo phạm vi hành nghề, năng lực và phân công đã được xác nhận. Bác sĩ xác lập chỉ định; điều dưỡng chuẩn bị, hỗ trợ và theo dõi, chỉ trực tiếp thực hiện thao tác thuộc phạm vi được giao.

5.2. Thuốc

Thuốc tê Alcain 0.5%.

Dùng theo y lệnh và đúng nhãn chế phẩm; xác nhận dị ứng, nồng độ, liều, đường dùng, mắt và hạn dùng/hạn sau mở. Không áp dụng thuốc khi kỹ thuật không cần; không dùng chế phẩm sát khuẩn da thay dung dịch dùng cho mắt.

5.3. Vật tư

Que nông điểm lệ.

Bộ que thông lệ đạo với các cơ số khác nhau.

Dung dịch nước muối sinh lý 0.9%.

Bơm tiêm 5ml.

Gạc/tăm bông và dụng cụ tiếp xúc vết thương phải phù hợp vô khuẩn; vệ sinh tay, găng/bảo hộ theo nguy cơ. Mỗi mắt có vật tư làm sạch riêng; chuẩn bị hộp vật sắc nhọn khi liên quan.

5.4. Trang thiết bị

Kiểm tra hoạt động, hiệu chuẩn và IFU đúng model; khử khuẩn bề mặt dùng chung giữa người bệnh, xử lý dụng cụ tiếp xúc giác mạc theo quy trình đã xác nhận. Phương tiện cấp cứu sẵn tiếp cận.

5.5. Người bệnh

Được giải thích về mục đích và các thì của thủ thuật. Nếu là trẻ em, cần giải thích cho người nhà để phối hợp.

Giải thích, xác nhận hợp tác/đồng ý theo mức can thiệp; đánh giá bệnh nền, thuốc, dị ứng và đúng mắt cần thực hiện.

5.6. Hồ sơ bệnh án

Theo quy định của Bộ y tế.

Có chỉ định, đánh giá và thông tin cần thiết của đúng người; giấy đồng ý và hồ sơ phẫu thuật khi áp dụng.

5.7. Thời gian thực hiện kỹ thuật

Thời gian thực hiện kỹ thuật: khoảng 5 – 10 phút.

Thời gian trong nguồn chỉ là ước tính, không phải thời gian bắt buộc chờ; ghi thực tế và theo dõi theo tình trạng.

5.8. Địa điểm thực hiện kỹ thuật

Địa điểm thực hiện kỹ thuật: phòng thủ thuật.

5.9. Kiểm tra hồ sơ và người bệnh

Đối chiếu ít nhất hai định danh và đúng mắt/bên; kiểm tra chỉ định, nguy cơ, thuốc, dụng cụ, thiết bị, đồng ý và nhân lực. Dừng khi sai hoặc thiếu điều kiện, báo bác sĩ giải quyết.

6. TIẾN HÀNH QUY TRÌNH KỸ THUẬT

6.1. Xác nhận và chuẩn bị thao tác

Thực hiện kiểm tra mục 5.9, vệ sinh tay và bố trí người bệnh; các bước dưới đây thực hiện bởi người đủ phạm vi và năng lực theo phân công.

6.2. Thực hiện kỹ thuật

Đặt tư thế phù hợp, giữ đầu an toàn; với trẻ em cần kế hoạch hỗ trợ/gây tê hoặc gây mê do bác sĩ quyết định, không cưỡng ép giữ trẻ để thông khi không bảo đảm an toàn.

Dùng thuốc tê theo y lệnh và nhãn chế phẩm, đánh giá hiệu lực trước thao tác.

Người làm thủ thuật đứng ở phía đầu người bệnh.

Bộc lộ điểm lệ; người thực hiện dùng dụng cụ vô khuẩn phù hợp nong nhẹ theo trục giải phẫu. Không dùng thuốc đỏ hoặc xanh methylen không được xác nhận chỉ định dùng cho mắt.

Đưa que thông vào lệ quản theo kỹ thuật và cỡ phù hợp; phân biệt điểm dừng mềm/cứng. Khi gặp kháng lực bất thường, dừng đánh giá; không cố đẩy qua để tạo đường giả.

Bác sĩ thực hiện thông ống lệ mũi theo giải phẫu và kỹ thuật được phê duyệt, tránh tạo đường giả; rút dụng cụ và bơm kiểm tra nhẹ khi phù hợp. Các góc, độ sâu và thời điểm lặp lại phải theo tuổi, kỹ thuật và đánh giá bác sĩ; sửa lỗi "900" và độ sâu sai đơn vị trong nguồn bằng hướng dẫn chuyên khoa đã xác nhận trước áp dụng.

Ghi hồ sơ

Thu dọn dụng cụ, rửa tay

Nếu sặc hoặc khó thở, dừng thủ thuật và đánh giá đường thở/hô hấp, gọi hỗ trợ; xử trí theo tình trạng và tuổi, không vỗ lưng mặc định.

Trẻ đang bị viêm đường hô hấp trên thì không nên làm thủ thuật này

6.3. Kết thúc và bàn giao

Đánh giá mắt và tình trạng người bệnh, ghi kết quả/thuốc/thao tác, diễn biến, giờ và người thực hiện; báo bác sĩ bất thường. Thu dọn, xử lý dụng cụ và chất thải đúng quy định; hướng dẫn chăm sóc và lịch khám, bàn giao khi chuyển.

7. THEO DÕI VÀ XỬ TRÍ TAI BIẾN

7.1. Trong thực hiện

Chảy máu: dừng, đánh giá vị trí và mức độ, cầm máu phù hợp và báo bác sĩ; chảy máu kéo dài cần khám, không chỉ ép vùng lệ đạo kéo dài.

Nghi que đi sai đường hoặc phù nhiều: dừng ngay, không thông lại bằng lực, báo bác sĩ Mắt đánh giá tổn thương; không mặc định băng ép hoặc thuốc chống phù nề.

Khi sai người/mắt, phản ứng thuốc, đau dữ dội, tổn thương hoặc diễn biến toàn thân bất thường: dừng, bảo đảm an toàn, báo bác sĩ, đánh giá và xử trí theo tình trạng. Phản vệ xử trí ngay theo Thông tư 51/2017/TT-BYT; không trì hoãn cấp cứu để hoàn tất hồ sơ.

7.2. Sau thực hiện

Theo dõi đau, đỏ mắt, chảy máu và thị lực theo kỹ thuật. Giảm thị lực, đau tăng, sợ sáng hoặc khó chịu kéo dài cần bác sĩ khám. Không chỉ băng mắt hoặc tự cho thuốc để thay khám nguyên nhân. Thuốc và băng theo y lệnh.

7.3. Theo dõi muộn

Hướng dẫn không dụi mắt, dùng thuốc đúng đơn và tái khám theo chỉ định; quay lại ngay khi đau tăng, nhìn mờ hoặc triệu chứng xấu đi. Ghi và báo cáo sự cố, đánh giá lại trước thực hiện tiếp; không khẳng định tuyệt đối "không tai biến".

Tài liệu tham khảo

QĐ3023/QĐ-BYT ngày 28/7/2023 về đề cương. Tài liệu nguồn QTKT DD năm 2025 do bệnh viện cung cấp. QĐ3517/QĐ-BYT ngày 12/11/2025 về Mắt Tập 1: cần đối chiếu đầy đủ đúng mục kỹ thuật trước ban hành. IFU và nhãn thuốc thực tế phải được xác nhận; các nguồn an toàn tại phần đầu hỗ trợ rà soát, không thay thế chỉ định chuyên khoa.

Danh mục chuẩn bị của kỹ thuật

TT	Danh mục chuẩn bị	Đơn vị	Số lượng
1	Lao động trực tiếp		
1.1	Điều dưỡng chuyên khoa Mắt	Người	01
2	Thuốc (tên hoạt chất, nồng độ, hàm lượng, đường dùng/dạng dùng)		Theo y lệnh / nhãn
2.1	Nước muối sinh lý 0.9%	Chai	01
2.2	Alcain 0.5%	Chai	Theo y lệnh / nhãn
3	Vật tư (được sử dụng trực tiếp)		
3.1	Bơm tiêm 5ml	Cái	01
3.2	Kim đầu tù	Cái	01
3.3	Khẩu trang, gang tay sạch	Cái	01
4	Trang thiết bị (sử dụng trực tiếp)		
4.1	Bộ que thông lệ đạo	Bộ	01

Danh mục kế thừa từ nguồn để đối chiếu, phải điều chỉnh đúng thiết bị và chỉ định; không thay thế các điều kiện mục 5. Thuốc/thiết bị có thông tin chưa xác nhận thì chưa sử dụng.

M-06. QUY TRÌNH CHỤP ĐÁY MẮT

1. ĐẠI CƯƠNG

Là phương pháp thăm dò hình ảnh không xâm lấn nhằm đánh giá võng mạc, hệ mạch võng mạc, và gai thị.

2. CHỈ ĐỊNH

Các trường hợp cần thăm dò xác định các bệnh lý võng mạc, hệ mạch võng mạc, gai thị.

3. CHỐNG CHỈ ĐỊNH

Đánh giá tình trạng mắt và khả năng phối hợp; có bệnh cấp cần bác sĩ lựa chọn thời điểm/phương pháp, không coi mọi viêm mắt là chống chỉ định tuyệt đối của chụp không tiếp xúc.

Những bệnh nhân không ngồi được, bệnh nhân có những bệnh toàn thân không cho phép.

4. THẬN TRỌNG

Xác định đúng người và mắt/bên; đánh giá dị ứng, thuốc và khả năng phối hợp. Đau tăng hoặc giảm thị lực cần bác sĩ đánh giá. Không để phép đo/thủ thuật trì hoãn cấp cứu; tránh ép nhãn cầu khi nghi vết thương hở. Trẻ em cần cách hỗ trợ và kế hoạch vô cảm phù hợp, không cố làm khi không an toàn.

5. CHUẨN BỊ

5.1. Người thực hiện

Người thực hiện: Điều dưỡng chuyên khoa Mắt.

Theo phạm vi hành nghề, năng lực và phân công đã được xác nhận. Bác sĩ xác lập chỉ định; điều dưỡng chuẩn bị, hỗ trợ và theo dõi, chỉ trực tiếp thực hiện thao tác thuộc phạm vi được giao.

5.2. Thuốc

Thuốc giãn đồng tử chỉ khi có y lệnh và đã đánh giá chống chỉ định theo đúng chế phẩm; không mặc định mọi lần chụp phải dùng Mydrin-P.

Dùng theo y lệnh và đúng nhãn chế phẩm; xác nhận dị ứng, nồng độ, liều, đường dùng, mắt và hạn dùng/hạn sau mở. Không áp dụng thuốc khi kỹ thuật không cần; không dùng chế phẩm sát khuẩn da thay dung dịch dùng cho mắt.

5.3. Vật tư

Gạc/tăm bông và dụng cụ tiếp xúc vết thương phải phù hợp vô khuẩn; vệ sinh tay, găng/bảo hộ theo nguy cơ. Mỗi mắt có vật tư làm sạch riêng; chuẩn bị hộp vật sắc nhọn khi liên quan.

5.4. Trang thiết bị

Máy chụp hình đáy mắt kỹ thuật số.

Kiểm tra hoạt động, hiệu chuẩn và IFU đúng model; khử khuẩn bề mặt dùng chung giữa người bệnh, xử lý dụng cụ tiếp xúc giác mạc theo quy trình đã xác nhận. Phương tiện cấp cứu sẵn tiếp cận.

5.5. Người bệnh

Được giải thích về mục đích và các thì của thủ thuật.

Giải thích, xác nhận hợp tác/đồng ý theo mức can thiệp; đánh giá bệnh nền, thuốc, dị ứng và đúng mắt cần thực hiện.

5.6. Hồ sơ bệnh án

Theo quy định của Bộ y tế.

Có chỉ định, đánh giá và thông tin cần thiết của đúng người; giấy đồng ý và hồ sơ phẫu thuật khi áp dụng.

5.7. Thời gian thực hiện kỹ thuật

Thời gian thực hiện kỹ thuật: khoảng 5 – 10 phút.

Thời gian trong nguồn chỉ là ước tính, không phải thời gian bắt buộc chờ; ghi thực tế và theo dõi theo tình trạng.

5.8. Địa điểm thực hiện kỹ thuật

Địa điểm thực hiện kỹ thuật: phòng chụp đáy mắt.

5.9. Kiểm tra hồ sơ và người bệnh

Đối chiếu ít nhất hai định danh và đúng mắt/bên; kiểm tra chỉ định, nguy cơ, thuốc, dụng cụ, thiết bị, đồng ý và nhân lực. Dừng khi sai hoặc thiếu điều kiện, báo bác sĩ giải quyết.

6. TIẾN HÀNH QUY TRÌNH KỸ THUẬT

6.1. Xác nhận và chuẩn bị thao tác

Thực hiện kiểm tra mục 5.9, vệ sinh tay và bố trí người bệnh; các bước dưới đây thực hiện bởi người đủ phạm vi và năng lực theo phân công.

6.2. Thực hiện kỹ thuật

Cho tư thế phù hợp máy và tình trạng; máy để bàn thường dùng tư thế ngồi với tì trán/cằm.

Kiểm tra thị lực

Nếu cần giãn đồng tử, kiểm tra chỉ định, dị ứng và nguy cơ góc đóng; nhỏ đúng mắt, đúng liều theo y lệnh/nhãn. Chụp khi đủ điều kiện theo máy, không lấy 15 phút làm bảo đảm cho mọi người bệnh.

Bật công tác máy, lưu ý không để cằm người bệnh trong lúc khởi động máy..

Kiểm tra chế độ cài đặt, chế độ chụp và tiêu cự phù hợp.

Yêu cầu người bệnh đặt cằm vào giá đỡ, trán áp sát vào băng tì trán.

Kiểm tra để đảm bảo mắt người bệnh ngang vị trí đánh dấu trên giá cố định đầu.

Hướng dẫn nhìn điểm định thị theo đúng model; không mặc định đèn xanh chớp là điểm định thị của mọi máy.

Chỉnh máy bằng công tắc trên chính giữa máy, khi nào thấy rõ ảnh võng mạc và tiêu cự phù hợp thì chụp (Chụp ảnh màu và chụp có bộ lọc tùy theo chỉ định)

Chọn hình ảnh phù hợp và ghi kết quả của bác sĩ đọc và lưu và hồ sơ điện tử.

Lưu và in kết quả.

Ghi kết quả chụp vào bệnh án điện tử.

Tắt máy và cố định máy.

6.3. Kết thúc và bàn giao

Đánh giá mắt và tình trạng người bệnh, ghi kết quả/thuốc/thao tác, diễn biến, giờ và người thực hiện; báo bác sĩ bất thường. Thu dọn, xử lý dụng cụ và chất thải đúng quy định; hướng dẫn chăm sóc và lịch khám, bàn giao khi chuyển.

7. THEO DÕI VÀ XỬ TRÍ TAI BIẾN

7.1. Trong thực hiện

Theo dõi khó chịu, dị ứng và phản ứng thuốc giãn đồng tử. Đau mắt dữ dội, nhìn mờ, quầng sáng, đau đầu hoặc buồn nôn sau giãn đồng tử cần bác sĩ đánh giá khẩn. Dặn tránh lái xe khi còn nhìn mờ/chói.

Khi sai người/mắt, phản ứng thuốc, đau dữ dội, tổn thương hoặc diễn biến toàn thân bất thường: dừng, bảo đảm an toàn, báo bác sĩ, đánh giá và xử trí theo tình trạng. Phản vệ xử trí ngay theo Thông tư 51/2017/TT-BYT; không trì hoãn cấp cứu để hoàn tất hồ sơ.

7.2. Sau thực hiện

Theo dõi đau, đỏ mắt, chảy máu và thị lực theo kỹ thuật. Giảm thị lực, đau tăng, sợ sáng hoặc khó chịu kéo dài cần bác sĩ khám. Không chỉ băng mắt hoặc tự cho thuốc để thay khám nguyên nhân. Thuốc và băng theo y lệnh.

7.3. Theo dõi muộn

Hướng dẫn không dụi mắt, dùng thuốc đúng đơn và tái khám theo chỉ định; quay lại ngay khi đau tăng, nhìn mờ hoặc triệu chứng xấu đi. Ghi và báo cáo sự cố, đánh giá lại trước thực hiện tiếp; không khẳng định tuyệt đối “không tai biến”.

Tài liệu tham khảo

QĐ3023/QĐ-BYT ngày 28/7/2023 về đề cương. Tài liệu nguồn QTKT DD năm 2025 do bệnh viện cung cấp. QĐ3517/QĐ-BYT ngày 12/11/2025 về Mắt Tập 1: cần đối chiếu đầy đủ đúng mục kỹ thuật trước ban hành. IFU và nhãn thuốc thực tế phải được xác nhận; các nguồn an toàn tại phần đầu hỗ trợ rà soát, không thay thế chỉ định chuyên khoa.

Danh mục chuẩn bị của kỹ thuật

TT	Danh mục chuẩn bị	Đơn vị	Số lượng
1	Lao động trực tiếp		

TT	Danh mục chuẩn bị	Đơn vị	Số lượng
1.1	Điều dưỡng chuyên khoa Mắt	Người	01
2	Thuốc (tên hoạt chất, nồng độ, hàm lượng, đường dùng/dạng dùng)		Theo y lệnh / nhãn
2.1	Mydrin-P	Chai	01
3	Vật tư (được sử dụng trực tiếp)		
3.1			
3.2			
3.3			
4	Trang thiết bị (sử dụng trực tiếp)		
4.1	Máy chụp đáy mắt kỹ thuật số	Cái	01

Danh mục kế thừa từ nguồn để đối chiếu, phải điều chỉnh đúng thiết bị và chỉ định; không thay thế các điều kiện mục 5. Thuốc/thiết bị có thông tin chưa xác nhận thì chưa sử dụng.

M-07. QUY TRÌNH RỬA – NHỎ MẮT – THAY BĂNG

1. ĐẠI CƯƠNG

Làm sạch mắt

Ngăn ngừa, che chở mắt tránh nhiễm trùng.

Thấm hút dịch tiết

2. CHỈ ĐỊNH

II. CHỈ ĐỊNH

Các trường hợp người bệnh trước và sau phẫu thuật mắt, các bệnh về mắt cần nhỏ thuốc điều trị, thăm dò chức năng khi có chỉ định.

3. CHỐNG CHỈ ĐỊNH

Dị ứng thuốc/dung dịch dự định dùng; nghi nhãn cầu hở không thực hiện rửa thường quy, băng ép hoặc đè mắt. Người không hợp tác cần hỗ trợ phù hợp, không tự bỏ chăm sóc.

4. THẬN TRỌNG

Xác định đúng người và mắt/bên; đánh giá dị ứng, thuốc và khả năng phối hợp. Đau tăng hoặc giảm thị lực cần bác sĩ đánh giá. Không để phép đo/thủ thuật trì hoãn cấp cứu; tránh ép nhãn cầu khi nghi vết thương hở. Trẻ em cần cách hỗ trợ và kế hoạch vô cảm phù hợp, không cố làm khi không an toàn.

5. CHUẨN BỊ

5.1. Người thực hiện

Người thực hiện: Điều dưỡng chuyên khoa Mắt.

Theo phạm vi hành nghề, năng lực và phân công đã được xác nhận. Bác sĩ xác lập chỉ định; điều dưỡng chuẩn bị, hỗ trợ và theo dõi, chỉ trực tiếp thực hiện thao tác thuộc phạm vi được giao.

5.2. Thuốc

Thuốc tê chỉ khi có chỉ định; không dùng thường quy cho mọi lần vệ sinh hoặc thay băng mắt.

Thuốc rửa mắt: Col. Natricorua 0,9%

Thuốc nhỏ kháng sinh, kháng viêm, kháng nấm theo y lệnh….

Dùng theo y lệnh và đúng nhãn chế phẩm; xác nhận dị ứng, nồng độ, liều, đường dùng, mắt và hạn dùng/hạn sau mở. Không áp dụng thuốc khi kỹ thuật không cần; không dùng chế phẩm sát khuẩn da thay dung dịch dùng cho mắt.

5.3. Vật tư

Gạc vô trùng

Găng tay sạch.

Gạc/tăm bông và dụng cụ tiếp xúc vết thương phải phù hợp vô khuẩn; vệ sinh tay, găng/bảo hộ theo nguy cơ. Mỗi mắt có vật tư làm sạch riêng; chuẩn bị hộp vật sắc nhọn khi liên quan.

5.4. Trang thiết bị

Kiểm tra hoạt động, hiệu chuẩn và IFU đúng model; khử khuẩn bề mặt dùng chung giữa người bệnh, xử lý dụng cụ tiếp xúc giác mạc theo quy trình đã xác nhận. Phương tiện cấp cứu sẵn tiếp cận.

5.5. Người bệnh

Được giải thích về mục đích và các thì của thủ thuật.

Giải thích, xác nhận hợp tác/đồng ý theo mức can thiệp; đánh giá bệnh nền, thuốc, dị ứng và đúng mắt cần thực hiện.

5.6. Hồ sơ bệnh án

Theo quy định của Bộ y tế.

Có chỉ định, đánh giá và thông tin cần thiết của đúng người; giấy đồng ý và hồ sơ phẫu thuật khi áp dụng.

5.7. Thời gian thực hiện kỹ thuật

Thời gian thực hiện kỹ thuật: khoảng 5 – 10 phút.

Thời gian trong nguồn chỉ là ước tính, không phải thời gian bắt buộc chờ; ghi thực tế và theo dõi theo tình trạng.

5.8. Địa điểm thực hiện kỹ thuật

Địa điểm thực hiện kỹ thuật: phòng thủ thuật.

5.9. Kiểm tra hồ sơ và người bệnh

Đối chiếu ít nhất hai định danh và đúng mắt/bên; kiểm tra chỉ định, nguy cơ, thuốc, dụng cụ, thiết bị, đồng ý và nhân lực. Dừng khi sai hoặc thiếu điều kiện, báo bác sĩ giải quyết.

6. TIẾN HÀNH QUY TRÌNH KỸ THUẬT

6.1. Xác nhận và chuẩn bị thao tác

Thực hiện kiểm tra mục 5.9, vệ sinh tay và bố trí người bệnh; các bước dưới đây thực hiện bởi người đủ phạm vi và năng lực theo phân công.

6.2. Thực hiện kỹ thuật

Hướng dẫn bệnh nhân nằm ngửa đầu bằng hoặc kê gối thấp

Hướng dẫn bệnh nhân nằm ngửa đầu bằng, hoặc ngồi cho thuận tiện

Vệ sinh tay, sử dụng găng theo chỉ định; tháo băng cũ, quan sát dịch/vết thương và báo bác sĩ khi bất thường. Làm sạch bằng gạc vô khuẩn từng lượt, mỗi mắt bộ vật tư riêng; không kéo/ép vùng phẫu thuật.

Dùng ngón cái hoặc ngón trỏ kéo da mi dưới để lộ túi cùng dưới.

Hướng dẫn bệnh nhân liếc mắt lên trên

Đặt miếng gòn nơi đuôi mắt

Kiểm tra thuốc đúng người, mắt, tên, nồng độ, liều, hạn dùng/hạn sau mở. Nhỏ vào túi cùng dưới theo y lệnh, đầu lọ không chạm mắt, mi hoặc tay; giữ sạch đầu lọ, không dùng lọ nghi nhiễm bẩn.

Cho nhắm mắt nhẹ; ấn điểm lệ khi thích hợp với thuốc và chỉ định. Thấm phần dư bằng gạc sạch; các thuốc nhỏ khác nhau cách nhau theo hướng dẫn, thuốc mỡ dùng sau thuốc nhỏ khi có chỉ định.

Nhỏ thuốc điều trị theo y lệnh (Nếu có)

Băng mắt theo y lệnh

Thu dọnn dụng cụ.

Ghi hồ sơ.

6.3. Kết thúc và bàn giao

Đánh giá mắt và tình trạng người bệnh, ghi kết quả/thuốc/thao tác, diễn biến, giờ và người thực hiện; báo bác sĩ bất thường. Thu dọn, xử lý dụng cụ và chất thải đúng quy định; hướng dẫn chăm sóc và lịch khám, bàn giao khi chuyển.

7. THEO DÕI VÀ XỬ TRÍ TAI BIẾN

7.1. Trong thực hiện

- Nhầm lẫn người bệnh, nhầm lẫn mắt đo

- Dị ứng thuốc nhỏ mắt

Khi sai người/mắt, phản ứng thuốc, đau dữ dội, tổn thương hoặc diễn biến toàn thân bất thường: dừng, bảo đảm an toàn, báo bác sĩ, đánh giá và xử trí theo tình trạng. Phản vệ xử trí ngay theo Thông tư 51/2017/TT-BYT; không trì hoãn cấp cứu để hoàn tất hồ sơ.

7.2. Sau thực hiện

Theo dõi đau, đỏ mắt, chảy máu và thị lực theo kỹ thuật. Giảm thị lực, đau tăng, sợ sáng hoặc khó chịu kéo dài cần bác sĩ khám. Không chỉ băng mắt hoặc tự cho thuốc để thay khám nguyên nhân. Thuốc và băng theo y lệnh.

7.3. Theo dõi muộn

Hướng dẫn không dụi mắt, dùng thuốc đúng đơn và tái khám theo chỉ định; quay lại ngay khi đau tăng, nhìn mờ hoặc triệu chứng xấu đi. Ghi và báo cáo sự cố, đánh giá lại trước thực hiện tiếp; không khẳng định tuyệt đối “không tai biến”.

Tài liệu tham khảo

QĐ3023/QĐ-BYT ngày 28/7/2023 về đề cương. Tài liệu nguồn QTKT DD năm 2025 do bệnh viện cung cấp. QĐ3517/QĐ-BYT ngày 12/11/2025 về Mắt Tập 1: cần đối chiếu đầy đủ đúng mục kỹ thuật trước ban hành. IFU và nhãn thuốc thực tế phải được xác nhận; các nguồn an toàn tại phần đầu hỗ trợ rà soát, không thay thế chỉ định chuyên khoa.

Danh mục chuẩn bị của kỹ thuật

TT	Danh mục chuẩn bị	Đơn vị	Số lượng
1	Lao động trực tiếp		
1.1	Điều dưỡng chuyên khoa Mắt	Người	01
2	Thuốc (tên hoạt chất, nồng độ, hàm lượng, đường dùng/dạng dùng)		Theo y lệnh / nhãn
2.1	Alcain 0.5%	Chai	Theo y lệnh / nhãn
	Natricorua 0,9%	Chai	01
3	Vật tư (được sử dụng trực tiếp)		
3.1	Gạc vô trùng	Bịt	01
3.2	Găng tay sạch		
4	Trang thiết bị (sử dụng trực tiếp)		
4.1	Bình kiềm tiếp liệu vô khuẩn	Cái	01
4.2	Mâm Inox	Cái	01

Danh mục kế thừa từ nguồn để đối chiếu, phải điều chỉnh đúng thiết bị và chỉ định; không thay thế các điều kiện mục 5. Thuốc/thiết bị có thông tin chưa xác nhận thì chưa sử dụng.

M-08. QUY TRÌNH BÓC GIẢ MẠC

1. ĐẠI CƯƠNG

Giả mạc là lớp fibrin và thành phần viêm trên kết mạc; bác sĩ xác định chỉ định bóc, phân biệt màng thật hoặc tổn thương khác.

2. CHỈ ĐỊNH

Các trường hợp viêm kết mạc có giả mạc.

3. CHỐNG CHỈ ĐỊNH

Người bệnh không hợp tác, bệnh nhân có những bệnh toàn thân không cho phép.

4. THẬN TRỌNG

Xác định đúng người và mắt/bên; đánh giá dị ứng, thuốc và khả năng phối hợp. Đau tăng hoặc giảm thị lực cần bác sĩ đánh giá. Không để phép đo/thủ thuật trì hoãn cấp cứu; tránh ép nhãn cầu khi nghi vết thương hở. Trẻ em cần cách hỗ trợ và kế hoạch vô cảm phù hợp, không cố làm khi không an toàn.

Kỹ thuật có tiếp xúc mắt hoặc xâm lấn: xác nhận năng lực, dùng dụng cụ được xử lý đúng và bảo vệ giác mạc. Không cố đưa dụng cụ qua cản trở; nếu đau/chảy máu bất thường phải dừng.

5. CHUẨN BỊ

5.1. Người thực hiện

Người thực hiện: Điều dưỡng chuyên khoa Mắt.

Theo phạm vi hành nghề, năng lực và phân công đã được xác nhận. Bác sĩ xác lập chỉ định; điều dưỡng chuẩn bị, hỗ trợ và theo dõi, chỉ trực tiếp thực hiện thao tác thuộc phạm vi được giao.

5.2. Thuốc

Thuốc nhỏ tê Alcain 0.5%

Thuốc rửa mắt: Col. Natricorua 0,9%

Thuốc nhỏ kháng sinh, kháng viêm, kháng nấm theo y lệnh….

Dùng theo y lệnh và đúng nhãn chế phẩm; xác nhận dị ứng, nồng độ, liều, đường dùng, mắt và hạn dùng/hạn sau mở. Không áp dụng thuốc khi kỹ thuật không cần; không dùng chế phẩm sát khuẩn da thay dung dịch dùng cho mắt.

5.3. Vật tư

Mâm Inox vô khuẩn đựng: Gòn ướt, que tăm bông vô khuẩn, nhíp vô khuẩn không mấu, găng tay sạch, Bình kiềm

Găng tay sạch.

Gạc/tăm bông và dụng cụ tiếp xúc vết thương phải phù hợp vô khuẩn; vệ sinh tay, găng/bảo hộ theo nguy cơ. Mỗi mắt có vật tư làm sạch riêng; chuẩn bị hộp vật sắc nhọn khi liên quan.

5.4. Trang thiết bị

Kiểm tra hoạt động, hiệu chuẩn và IFU đúng model; khử khuẩn bề mặt dùng chung giữa người bệnh, xử lý dụng cụ tiếp xúc giác mạc theo quy trình đã xác nhận. Phương tiện cấp cứu sẵn tiếp cận.

5.5. Người bệnh

Được giải thích về mục đích và các thì của thủ thuật.

Giải thích, xác nhận hợp tác/đồng ý theo mức can thiệp; đánh giá bệnh nền, thuốc, dị ứng và đúng mắt cần thực hiện.

5.6. Hồ sơ bệnh án

Theo quy định của Bộ y tế.

Có chỉ định, đánh giá và thông tin cần thiết của đúng người; giấy đồng ý và hồ sơ phẫu thuật khi áp dụng.

5.7. Thời gian thực hiện kỹ thuật

Thời gian thực hiện kỹ thuật: khoảng 5 – 10 phút.

Thời gian trong nguồn chỉ là ước tính, không phải thời gian bắt buộc chờ; ghi thực tế và theo dõi theo tình trạng.

5.8. Địa điểm thực hiện kỹ thuật

Địa điểm thực hiện kỹ thuật: phòng thủ thuật.

5.9. Kiểm tra hồ sơ và người bệnh

Đối chiếu ít nhất hai định danh và đúng mắt/bên; kiểm tra chỉ định, nguy cơ, thuốc, dụng cụ, thiết bị, đồng ý và nhân lực. Dừng khi sai hoặc thiếu điều kiện, báo bác sĩ giải quyết.

6. TIẾN HÀNH QUY TRÌNH KỸ THUẬT

6.1. Xác nhận và chuẩn bị thao tác

Thực hiện kiểm tra mục 5.9, vệ sinh tay và bố trí người bệnh; các bước dưới đây thực hiện bởi người đủ phạm vi và năng lực theo phân công.

6.2. Thực hiện kỹ thuật

Hướng dẫn bệnh nhân nằm ngửa đầu bằng hoặc kê gối thấp.

Điều dưỡng ngồi ở phía đỉnh đầu bệnh nhân.

Rửa sạch mắt bệnh nhân.

Nhỏ thuốc tê theo y lệnh/nhãn, kiểm tra dị ứng và hiệu lực; không ấn định lịch lặp giống nhau cho mọi người bệnh.

Điều dưỡng mang khẩu trang, rửa tay, mang găng

Một tay lật mi bệnh nhân

Người thực hiện trong phạm vi được phép dùng tăm bông vô khuẩn ẩm hoặc nhíp phù hợp bóc nhẹ lớp giả mạc; không cố kéo lớp dính chắc gây tổn thương, dừng khi đau/chảy máu bất thường và báo bác sĩ.

Làm sạch bằng dung dịch dùng cho mắt theo chỉ định; thuốc sau thủ thuật đúng y lệnh, không mặc định Vigamox hai giọt cho mọi trường hợp.

Không tự phối hợp nhiều kháng sinh hoặc thuốc kháng viêm; ghi thuốc và đáp ứng theo y lệnh.

6.3. Kết thúc và bàn giao

Đánh giá mắt và tình trạng người bệnh, ghi kết quả/thuốc/thao tác, diễn biến, giờ và người thực hiện; báo bác sĩ bất thường. Thu dọn, xử lý dụng cụ và chất thải đúng quy định; hướng dẫn chăm sóc và lịch khám, bàn giao khi chuyển.

7. THEO DÕI VÀ XỬ TRÍ TAI BIẾN

7.1. Trong thực hiện

Chảy máu: dừng, đánh giá và báo bác sĩ; cầm máu phù hợp, không băng ép nhãn cầu khi chưa loại trừ tổn thương.

Nghi trợt giác mạc, đau tăng hoặc giảm thị lực: bác sĩ khám và điều trị; điều dưỡng theo dõi, không tự kê kháng sinh/vitamin A.

Khi sai người/mắt, phản ứng thuốc, đau dữ dội, tổn thương hoặc diễn biến toàn thân bất thường: dừng, bảo đảm an toàn, báo bác sĩ, đánh giá và xử trí theo tình trạng. Phản vệ xử trí ngay theo Thông tư 51/2017/TT-BYT; không trì hoãn cấp cứu để hoàn tất hồ sơ.

7.2. Sau thực hiện

Theo dõi đau, đỏ mắt, chảy máu và thị lực theo kỹ thuật. Giảm thị lực, đau tăng, sợ sáng hoặc khó chịu kéo dài cần bác sĩ khám. Không chỉ băng mắt hoặc tự cho thuốc để thay khám nguyên nhân. Thuốc và băng theo y lệnh.

7.3. Theo dõi muộn

Hướng dẫn không dụi mắt, dùng thuốc đúng đơn và tái khám theo chỉ định; quay lại ngay khi đau tăng, nhìn mờ hoặc triệu chứng xấu đi. Ghi và báo cáo sự cố, đánh giá lại trước thực hiện tiếp; không khẳng định tuyệt đối “không tai biến”.

Tài liệu tham khảo

QĐ3023/QĐ-BYT ngày 28/7/2023 về đề cương. Tài liệu nguồn QTKT DD năm 2025 do bệnh viện cung cấp. QĐ3517/QĐ-BYT ngày 12/11/2025 về Mắt Tập 1: cần đối chiếu đầy đủ đúng mục kỹ thuật trước ban hành. IFU và nhãn thuốc thực tế phải được xác nhận; các nguồn an toàn tại phần đầu hỗ trợ rà soát, không thay thế chỉ định chuyên khoa.

Danh mục chuẩn bị của kỹ thuật

TT	Danh mục chuẩn bị	Đơn vị	Số lượng
1	Lao động trực tiếp		
1.1	Điều dưỡng chuyên khoa Mắt	Người	01

TT	Danh mục chuẩn bị	Đơn vị	Số lượng
2	Thuốc (tên hoạt chất, nồng độ, hàm lượng, đường dùng/dạng dùng)		Theo y lệnh / nhãn
2.1	Alcain 0.5%	Chai	Theo y lệnh / nhãn
2.2	Natricorua 0,9%	Chai	01
2.3	Thuốc kháng sinh tra	Chai	Theo y lệnh / nhãn
3	Vật tư (được sử dụng trực tiếp)		
3.1	Tâm bông vô trùng	Bịt	01
3.2	Găng tay sạch	Cặp	01
4	Trang thiết bị (sử dụng trực tiếp)		
4.1	Sinh hiển vi	Cái	01
4.2	Mâm Inox	Cái	01

Danh mục kế thừa từ nguồn để đối chiếu, phải điều chỉnh đúng thiết bị và chỉ định; không thay thế các điều kiện mục 5. Thuốc/thiết bị có thông tin chưa xác nhận thì chưa sử dụng.

M-09. QUY TRÌNH LẤY SẠN VÔI

1. ĐẠI CƯƠNG

Lấy sạn vôi với mục đích làm giảm cộm cho bệnh nhân.

2. CHỈ ĐỊNH

Các trường hợp có nhiều calci trên kết mạc gây cộm.

3. CHỐNG CHỈ ĐỊNH

Người bệnh không hợp tác,bệnh nhân có những bệnh toàn thân không cho phép.

4. THẬN TRỌNG

Xác định đúng người và mắt/bên; đánh giá dị ứng, thuốc và khả năng phối hợp. Đau tăng hoặc giảm thị lực cần bác sĩ đánh giá. Không để phép đo/thủ thuật trì hoãn cấp cứu; tránh ép nhãn cầu khi nghi vết thương hở. Trẻ em cần cách hỗ trợ và kế hoạch vô cảm phù hợp, không cố làm khi không an toàn.

Kỹ thuật có tiếp xúc mắt hoặc xâm lấn: xác nhận năng lực, dùng dụng cụ được xử lý đúng và bảo vệ giác mạc. Không cố đưa dụng cụ qua cản trở; nếu đau/chảy máu bất thường phải dừng.

5. CHUẨN BỊ

5.1. Người thực hiện

Người thực hiện: Điều dưỡng chuyên khoa Mắt.

Theo phạm vi hành nghề, năng lực và phân công đã được xác nhận. Bác sĩ xác lập chỉ định; điều dưỡng chuẩn bị, hỗ trợ và theo dõi, chỉ trực tiếp thực hiện thao tác thuộc phạm vi được giao.

5.2. Thuốc

Thuốc nhỏ tê Alcain 0.5%

Thuốc rửa mắt: Col. Natricorua 0,9%

Dùng theo y lệnh và đúng nhãn chế phẩm; xác nhận dị ứng, nồng độ, liều, đường dùng, mắt và hạn dùng/hạn sau mở. Không áp dụng thuốc khi kỹ thuật không cần; không dùng chế phẩm sát khuẩn da thay dung dịch dùng cho mắt.

5.3. Vật tư

Mâm Inox vô khuẩn đựng: Que tăm bông vô khuẩn, găng tay sạch, Bình kiềm

Bơm tiêm 1ml

Găng tay sạch.

Gạc/tăm bông và dụng cụ tiếp xúc vết thương phải phù hợp vô khuẩn; vệ sinh tay, găng/bảo hộ theo nguy cơ. Mỗi mắt có vật tư làm sạch riêng; chuẩn bị hộp vật sắc nhọn khi liên quan.

5.4. Trang thiết bị

Kiểm tra hoạt động, hiệu chuẩn và IFU đúng model; khử khuẩn bề mặt dùng chung giữa người bệnh, xử lý dụng cụ tiếp xúc giác mạc theo quy trình đã xác nhận. Phương tiện cấp cứu sẵn tiếp cận.

5.5. Người bệnh

Được giải thích về mục đích và các thì của thủ thuật.

Giải thích, xác nhận hợp tác/đồng ý theo mức can thiệp; đánh giá bệnh nền, thuốc, dị ứng và đúng mắt cần thực hiện.

5.6. Hồ sơ bệnh án

Theo quy định của Bộ y tế.

Có chỉ định, đánh giá và thông tin cần thiết của đúng người; giấy đồng ý và hồ sơ phẫu thuật khi áp dụng.

5.7. Thời gian thực hiện kỹ thuật

Thời gian thực hiện kỹ thuật: khoảng 5 – 10 phút.

Thời gian trong nguồn chỉ là ước tính, không phải thời gian bắt buộc chờ; ghi thực tế và theo dõi theo tình trạng.

5.8. Địa điểm thực hiện kỹ thuật

Địa điểm thực hiện kỹ thuật: phòng thủ thuật.

5.9. Kiểm tra hồ sơ và người bệnh

Đối chiếu ít nhất hai định danh và đúng mắt/bên; kiểm tra chỉ định, nguy cơ, thuốc, dụng cụ, thiết bị, đồng ý và nhân lực. Dừng khi sai hoặc thiếu điều kiện, báo bác sĩ giải quyết.

6. TIẾN HÀNH QUY TRÌNH KỸ THUẬT

6.1. Xác nhận và chuẩn bị thao tác

Thực hiện kiểm tra mục 5.9, vệ sinh tay và bố trí người bệnh; các bước dưới đây thực hiện bởi người đủ phạm vi và năng lực theo phân công.

6.2. Thực hiện kỹ thuật

Hướng dẫn bệnh nhân nằm ngửa đầu bằng hoặc kê gối thấp.

Điều dưỡng ngồi ở phía đỉnh đầu bệnh nhân.

Rửa sạch mắt bệnh nhân.

Dùng thuốc tê theo y lệnh và nhãn, xác nhận hiệu lực trước thao tác.

Điều dưỡng mang khẩu trang, rửa tay nhanh, mang găng sạch.

01 tay lật mi bộc lộ kết mạc

Người đủ phạm vi/năng lực dùng dụng cụ vô khuẩn phù hợp lấy nhẹ sạn trồi gây triệu chứng, bảo vệ giác mạc và cố định mi an toàn; không đào sâu để lấy toàn bộ sạn.

Rửa mắt bằng nước muối sinh lý hoặc thuốc theo chỉ định của bác sĩ.

Thu dọnn dụng cụ, rửa tay.

Ghi hồ sơ.

Lưu ý: khi lấy sạn vôi phải nhẹ nhàng, ưu tiên lấy những sạn vôi trồi lên bề mặt kết mạc, hạn chế lấy sâu, tổn thương kết mạc kết mạc gây chảy máu và nhiễm trùng tại mắt.

6.3. Kết thúc và bàn giao

Đánh giá mắt và tình trạng người bệnh, ghi kết quả/thuốc/thao tác, diễn biến, giờ và người thực hiện; báo bác sĩ bất thường. Thu dọn, xử lý dụng cụ và chất thải đúng quy định; hướng dẫn chăm sóc và lịch khám, bàn giao khi chuyển.

7. THEO DÕI VÀ XỬ TRÍ TAI BIẾN

7.1. Trong thực hiện

Chảy máu, đau tăng hoặc nghi trợt giác mạc: dừng, báo bác sĩ đánh giá, theo dõi thị lực và xử trí; không chỉ băng mắt rồi cho về.

Khi sai người/mắt, phản ứng thuốc, đau dữ dội, tổn thương hoặc diễn biến toàn thân bất thường: dừng, bảo đảm an toàn, báo bác sĩ, đánh giá và xử trí theo tình trạng. Phản vệ xử trí ngay theo Thông tư 51/2017/TT-BYT; không trì hoãn cấp cứu để hoàn tất hồ sơ.

7.2. Sau thực hiện

Theo dõi đau, đỏ mắt, chảy máu và thị lực theo kỹ thuật. Giảm thị lực, đau tăng, sợ sáng hoặc khó chịu kéo dài cần bác sĩ khám. Không chỉ băng mắt hoặc tự cho thuốc để thay khám nguyên nhân. Thuốc và băng theo y lệnh.

7.3. Theo dõi muộn

Hướng dẫn không dụi mắt, dùng thuốc đúng đơn và tái khám theo chỉ định; quay lại ngay khi đau tăng, nhìn mờ hoặc triệu chứng xấu đi. Ghi và báo cáo sự cố, đánh giá lại trước thực hiện tiếp; không khẳng định tuyệt đối “không tai biến”.

Tài liệu tham khảo

QĐ3023/QĐ-BYT ngày 28/7/2023 về đề cương. Tài liệu nguồn QTKT DD năm 2025 do bệnh viện cung cấp. QĐ3517/QĐ-BYT ngày 12/11/2025 về Mắt Tập 1: cần đối chiếu đầy đủ đúng mục kỹ thuật trước ban hành. IFU và nhãn thuốc thực tế phải được xác nhận; các nguồn an toàn tại phần đầu hỗ trợ rà soát, không thay thế chỉ định chuyên khoa.

Danh mục chuẩn bị của kỹ thuật

TT	Danh mục chuẩn bị	Đơn vị	Số lượng
1	Lao động trực tiếp		
1.1	Điều dưỡng chuyên khoa Mắt	Người	01

TT	Danh mục chuẩn bị	Đơn vị	Số lượng
2	Thuốc (tên hoạt chất, nồng độ, hàm lượng, đường dùng/dạng dùng)		Theo y lệnh / nhãn
2.1	Alcain 0.5%	Chai	Theo y lệnh / nhãn
2.2	Natricorua 0,9%	Chai	01
2.3	Thuốc kháng sinh tra	Chai	Theo y lệnh / nhãn
3	Vật tư (được sử dụng trực tiếp)		
3.1	Tâm bông vô trùng	Bịt	01
3.2	Găng tay sạch	Cặp	01
3.3	Bơm tiêm 1ml		
4	Trang thiết bị (sử dụng trực tiếp)		
4.1	Đèn phẫu thuật	Cái	01
4.2	Mâm Inox	Cái	01

Danh mục kế thừa từ nguồn để đối chiếu, phải điều chỉnh đúng thiết bị và chỉ định; không thay thế các điều kiện mục 5. Thuốc/thiết bị có thông tin chưa xác nhận thì chưa sử dụng.

M-10. QUY TRÌNH NẶN TUYẾN BỜ MI

1. ĐẠI CƯƠNG

Nặn tuyến bờ mi là kỹ thuật nhằm làm sạch bờ mi, đẩy các chất tiết của

tuyến bờ mi ra và đưa thuốc trực tiếp lên bờ mi.

2. CHỈ ĐỊNH

Các trường hợp viêm bờ mi mạn tính.

3. CHỐNG CHỈ ĐỊNH

Người bệnh không hợp tác,bệnh nhân có những bệnh toàn thân không cho phép.

4. THẬN TRỌNG

Xác định đúng người và mắt/bên; đánh giá dị ứng, thuốc và khả năng phối hợp. Đau tăng hoặc giảm thị lực cần bác sĩ đánh giá. Không để phép đo/thủ thuật trì hoãn cấp cứu; tránh ép nhãn cầu khi nghi vết thương hở. Trẻ em cần cách hỗ trợ và kế hoạch vô cảm phù hợp, không cố làm khi không an toàn.

Kỹ thuật có tiếp xúc mắt hoặc xâm lấn: xác nhận năng lực, dùng dụng cụ được xử lý đúng và bảo vệ giác mạc. Không cố đưa dụng cụ qua cản trở; nếu đau/chảy máu bất thường phải dừng.

5. CHUẨN BỊ

5.1. Người thực hiện

Người thực hiện: Điều dưỡng chuyên khoa Mắt.

Theo phạm vi hành nghề, năng lực và phân công đã được xác nhận. Bác sĩ xác lập chỉ định; điều dưỡng chuẩn bị, hỗ trợ và theo dõi, chỉ trực tiếp thực hiện thao tác thuộc phạm vi được giao.

5.2. Thuốc

Thuốc nhỏ tê Alcain 0.5%

Thuốc rửa mắt: Col. Natricorua 0,9%

Dùng theo y lệnh và đúng nhãn chế phẩm; xác nhận dị ứng, nồng độ, liều, đường dùng, mắt và hạn dùng/hạn sau mở. Không áp dụng thuốc khi kỹ thuật không cần; không dùng chế phẩm sát khuẩn da thay dung dịch dùng cho mắt.

5.3. Vật tư

Mâm Inox vô khuẩn đựng: Que tăm bông vô khuẩn, găng tay sạch, Bình kiềm

Găng tay sạch.

Gạc/tăm bông và dụng cụ tiếp xúc vết thương phải phù hợp vô khuẩn; vệ sinh tay, găng/bảo hộ theo nguy cơ. Mỗi mắt có vật tư làm sạch riêng; chuẩn bị hộp vật sắc nhọn khi liên quan.

5.4. Trang thiết bị

Kiểm tra hoạt động, hiệu chuẩn và IFU đúng model; khử khuẩn bề mặt dùng chung giữa người bệnh, xử lý dụng cụ tiếp xúc giác mạc theo quy trình đã xác nhận. Phương tiện cấp cứu sẵn tiếp cận.

5.5. Người bệnh

Được giải thích về mục đích và các thì của thủ thuật.

Giải thích, xác nhận hợp tác/đồng ý theo mức can thiệp; đánh giá bệnh nền, thuốc, dị ứng và đúng mắt cần thực hiện.

5.6. Hồ sơ bệnh án

Theo quy định của Bộ y tế.

Có chỉ định, đánh giá và thông tin cần thiết của đúng người; giấy đồng ý và hồ sơ phẫu thuật khi áp dụng.

5.7. Thời gian thực hiện kỹ thuật

Thời gian thực hiện kỹ thuật: khoảng 5 – 10 phút.

Thời gian trong nguồn chỉ là ước tính, không phải thời gian bắt buộc chờ; ghi thực tế và theo dõi theo tình trạng.

5.8. Địa điểm thực hiện kỹ thuật

Địa điểm thực hiện kỹ thuật: phòng thủ thuật.

5.9. Kiểm tra hồ sơ và người bệnh

Đối chiếu ít nhất hai định danh và đúng mắt/bên; kiểm tra chỉ định, nguy cơ, thuốc, dụng cụ, thiết bị, đồng ý và nhân lực. Dừng khi sai hoặc thiếu điều kiện, báo bác sĩ giải quyết.

6. TIẾN HÀNH QUY TRÌNH KỸ THUẬT

6.1. Xác nhận và chuẩn bị thao tác

Thực hiện kiểm tra mục 5.9, vệ sinh tay và bố trí người bệnh; các bước dưới đây thực hiện bởi người đủ phạm vi và năng lực theo phân công.

6.2. Thực hiện kỹ thuật

Hướng dẫn bệnh nhân nằm ngửa đầu bằng hoặc kê gối thấp.

Điều dưỡng ngồi ở phía đỉnh đầu bệnh nhân.

Rửa sạch mắt bệnh nhân.

Thuốc tê dùng khi có chỉ định và theo đúng nhãn/y lệnh.

Điều dưỡng mang khẩu trang, rửa tay, mang găng sạch.

Dùng dụng cụ phù hợp để đỡ mi, biểu lộ tuyến với lực có kiểm soát; tránh ấn mạnh lên nhãn cầu, dừng khi đau nhiều hoặc tổn thương bờ mi.

Nếu dùng kẹp chuyên dụng, thao tác theo hướng dẫn kỹ thuật đã được xác nhận; không áp dụng độ sâu 4–5 mm cố định cho mọi mi mắt. Làm sạch chất tiết bằng vật tư phù hợp.

Rửa mắt bằng nước muối sinh lý hoặc thuốc theo chỉ định của bác sĩ.

Thu dọnn dụng cụ, rửa tay.

Ghi hồ sơ.

6.3. Kết thúc và bàn giao

Đánh giá mắt và tình trạng người bệnh, ghi kết quả/thuốc/thao tác, diễn biến, giờ và người thực hiện; báo bác sĩ bất thường. Thu dọn, xử lý dụng cụ và chất thải đúng quy định; hướng dẫn chăm sóc và lịch khám, bàn giao khi chuyển.

7. THEO DÕI VÀ XỬ TRÍ TAI BIẾN

7.1. Trong thực hiện

Nghi nhiễm khuẩn, tổn thương giác mạc hoặc đau tăng: bác sĩ khám và chỉ định điều trị; không tự dùng kháng sinh toàn thân.

Khi sai người/mắt, phản ứng thuốc, đau dữ dội, tổn thương hoặc diễn biến toàn thân bất thường: dừng, bảo đảm an toàn, báo bác sĩ, đánh giá và xử trí theo tình trạng. Phản vệ xử trí ngay theo Thông tư 51/2017/TT-BYT; không trì hoãn cấp cứu để hoàn tất hồ sơ.

7.2. Sau thực hiện

Theo dõi đau, đỏ mắt, chảy máu và thị lực theo kỹ thuật. Giảm thị lực, đau tăng, sợ sáng hoặc khó chịu kéo dài cần bác sĩ khám. Không chỉ băng mắt hoặc tự cho thuốc để thay khám nguyên nhân. Thuốc và băng theo y lệnh.

7.3. Theo dõi muộn

Hướng dẫn không dụi mắt, dùng thuốc đúng đơn và tái khám theo chỉ định; quay lại ngay khi đau tăng, nhìn mờ hoặc triệu chứng xấu đi. Ghi và báo cáo sự cố, đánh giá lại trước thực hiện tiếp; không khẳng định tuyệt đối “không tai biến”.

Tài liệu tham khảo

QĐ3023/QĐ-BYT ngày 28/7/2023 về đề cương. Tài liệu nguồn QTKT DD năm 2025 do bệnh viện cung cấp. QĐ3517/QĐ-BYT ngày 12/11/2025 về Mắt Tập 1: cần đối chiếu đầy đủ đúng mục kỹ thuật trước ban hành. IFU và nhãn thuốc thực tế phải được xác nhận; các nguồn an toàn tại phần đầu hỗ trợ rà soát, không thay thế chỉ định chuyên khoa.

Danh mục chuẩn bị của kỹ thuật

TT	Danh mục chuẩn bị	Đơn vị	Số lượng
1	Lao động trực tiếp		
1.1	Điều dưỡng chuyên khoa Mắt	Người	01
2	Thuốc (tên hoạt chất, nồng độ, hàm lượng, đường dùng/dạng dùng)		Theo y lệnh / nhãn
2.1	Alcain 0.5%	Chai	Theo y lệnh / nhãn

TT	Danh mục chuẩn bị	Đơn vị	Số lượng
2.2	Natricorua 0,9%	Chai	01
2.3	Thuốc kháng sinh nhỏ	Chai	Theo y lệnh / nhãn
3	Vật tư (được sử dụng trực tiếp)		
3.1	Tâm bông vô trùng	Bịt	01
3.2	Găng tay sạch	Cặp	01
4	Trang thiết bị (sử dụng trực tiếp)		
4.1	Đèn phẫu thuật	Cái	01
4.2	Mâm Inox	Cái	01

Danh mục kế thừa từ nguồn để đối chiếu, phải điều chỉnh đúng thiết bị và chỉ định; không thay thế các điều kiện mục 5. Thuốc/thiết bị có thông tin chưa xác nhận thì chưa sử dụng.

M-11. QUY TRÌNH NHỔ LÔNG XIÊU – ĐỐT LÔNG XIÊU

1. ĐẠI CƯƠNG

Đốt lông xiêu hay nhổ lông xiêu là thủ thuật loại bỏ lông xiêu kích thích vào nhãn cầu.

2. CHỈ ĐỊNH

Các trường hợp mắt có lông xiêu.

3. CHỐNG CHỈ ĐỊNH

Người bệnh không hợp tác,bệnh nhân có những bệnh toàn thân không cho phép.

4. THẬN TRỌNG

Xác định đúng người và mắt/bên; đánh giá dị ứng, thuốc và khả năng phối hợp. Đau tăng hoặc giảm thị lực cần bác sĩ đánh giá. Không để phép đo/thủ thuật trì hoãn cấp cứu; tránh ép nhãn cầu khi nghi vết thương hở. Trẻ em cần cách hỗ trợ và kế hoạch vô cảm phù hợp, không cố làm khi không an toàn.

Kỹ thuật có tiếp xúc mắt hoặc xâm lấn: xác nhận năng lực, dùng dụng cụ được xử lý đúng và bảo vệ giác mạc. Không cố đưa dụng cụ qua cản trở; nếu đau/chảy máu bất thường phải dừng.

5. CHUẨN BỊ

5.1. Người thực hiện

Người thực hiện: Điều dưỡng chuyên khoa Mắt.

Theo phạm vi hành nghề, năng lực và phân công đã được xác nhận. Bác sĩ xác lập chỉ định; điều dưỡng chuẩn bị, hỗ trợ và theo dõi, chỉ trực tiếp thực hiện thao tác thuộc phạm vi được giao.

5.2. Thuốc

Thuốc nhỏ tê Alcain 0.5%

Thuốc rửa mắt: Col. Natricorua 0,9%

Thuốc tra mắt oflovid

Dùng theo y lệnh và đúng nhãn chế phẩm; xác nhận dị ứng, nồng độ, liều, đường dùng, mắt và hạn dùng/hạn sau mở. Không áp dụng thuốc khi kỹ thuật không cần; không dùng chế phẩm sát khuẩn da thay dung dịch dùng cho mắt.

5.3. Vật tư

Mâm Inox vô khuẩn đựng: Que tăm bông vô khuẩn, găng tay sạch, Bình kiềm

Găng tay sạch.

Bơm tiêm 1ml

Gạc/tăm bông và dụng cụ tiếp xúc vết thương phải phù hợp vô khuẩn; vệ sinh tay, găng/bảo hộ theo nguy cơ. Mỗi mắt có vật tư làm sạch riêng; chuẩn bị hộp vật sắc nhọn khi liên quan.

5.4. Trang thiết bị

Máy đốt cao tần.

Kiểm tra hoạt động, hiệu chuẩn và IFU đúng model; khử khuẩn bề mặt dùng chung giữa người bệnh, xử lý dụng cụ tiếp xúc giác mạc theo quy trình đã xác nhận. Phương tiện cấp cứu sẵn tiếp cận.

5.5. Người bệnh

Được giải thích về mục đích và các thì của thủ thuật.

Giải thích, xác nhận hợp tác/đồng ý theo mức can thiệp; đánh giá bệnh nền, thuốc, dị ứng và đúng mắt cần thực hiện.

5.6. Hồ sơ bệnh án

Theo quy định của Bộ y tế.

Có chỉ định, đánh giá và thông tin cần thiết của đúng người; giấy đồng ý và hồ sơ phẫu thuật khi áp dụng.

5.7. Thời gian thực hiện kỹ thuật

Thời gian thực hiện kỹ thuật: khoảng 5 – 10 phút.

Thời gian trong nguồn chỉ là ước tính, không phải thời gian bắt buộc chờ; ghi thực tế và theo dõi theo tình trạng.

5.8. Địa điểm thực hiện kỹ thuật

Địa điểm thực hiện kỹ thuật: phòng thủ thuật.

5.9. Kiểm tra hồ sơ và người bệnh

Đối chiếu ít nhất hai định danh và đúng mắt/bên; kiểm tra chỉ định, nguy cơ, thuốc, dụng cụ, thiết bị, đồng ý và nhân lực. Dừng khi sai hoặc thiếu điều kiện, báo bác sĩ giải quyết.

6. TIẾN HÀNH QUY TRÌNH KỸ THUẬT

6.1. Xác nhận và chuẩn bị thao tác

Thực hiện kiểm tra mục 5.9, vệ sinh tay và bố trí người bệnh; các bước dưới đây thực hiện bởi người đủ phạm vi và năng lực theo phân công.

6.2. Thực hiện kỹ thuật

3.1: Nhổ lông xiêu

Hướng dẫn bệnh nhân nằm ngửa đầu bằng hoặc kê gối thấp.

Điều dưỡng ngồi ở phía đỉnh đầu bệnh nhân.

Rửa sạch mắt bệnh nhân.

Nhỏ thuốc tê theo y lệnh/nhãn khi có chỉ định.

Điều dưỡng mang khẩu trang, rửa tay, mang găng sạch.

Tay trái lật mi bệnh nhân, tay phải dùng nhíp nhổ sạch lông xiêu.

Rửa mắt bằng nước muối sinh lý 0,9%.

Thuốc mỡ sau nhổ theo y lệnh; nhổ chỉ là giải pháp tạm thời, giải thích nguy cơ lông mọc lại.

3.2: Đốt lông xiêu

Hướng dẫn bệnh nhân nằm ngửa đầu bằng hoặc kê gối thấp.

Điều dưỡng ngồi ở phía đỉnh đầu bệnh nhân.

Rửa sạch mắt bệnh nhân.

Kiểm tra đúng máy cao tần, đầu đốt và thông số theo hướng dẫn sử dụng/y lệnh đã xác nhận; không mặc định công tắc số 3.

Thử máy.

Dùng thuốc tê theo y lệnh và đánh giá hiệu lực.

Điều dưỡng mang khẩu trang, rửa tay, mang găng vô trùng

Chuẩn bị thuốc tê tiêm đúng chế phẩm, nồng độ và tổng liều do bác sĩ xác nhận; kiểm tra độc lập khi quy định yêu cầu.

Thử kim

Hướng dẫn bệnh nhân liếc mắt lên trên, hoặc xuống dưới tùy theo vị trí đốt mi dưới thì liếc lên, mi trên thì liếc mắt xuống.

Bác sĩ/người được phép thực hiện gây tê tại chỗ theo giải phẫu mi và kế hoạch liều, tránh nhãn cầu; điều dưỡng hỗ trợ, không mặc định tự tiêm.

Dùng gòn ấn nhẹ lên chỗ rút kim.

Người được phép thực hiện đốt nang lông theo kỹ thuật và thông số đã xác nhận, bảo vệ giác mạc, tránh bỏng/sẹo bờ mi. Kiểm soát cháy khi sử dụng năng lượng.

Rửa mắt bằng nước muối sinh lý hoặc thuốc theo chỉ định của bác sĩ.

Tra mỡ kháng sinh theo y lệnh

Thu dọnn dụng cụ, rửa tay.

Ghi hồ sơ.

6.3. Kết thúc và bàn giao

Đánh giá mắt và tình trạng người bệnh, ghi kết quả/thuốc/thao tác, diễn biến, giờ và người thực hiện; báo bác sĩ bất thường. Thu dọn, xử lý dụng cụ và chất thải đúng quy định; hướng dẫn chăm sóc và lịch khám, bàn giao khi chuyển.

7. THEO DÕI VÀ XỬ TRÍ TAI BIẾN

7.1. Trong thực hiện

Tổn thương bờ mi, sẹo xấu, tổn thương giác mạc: Khi thực hiện thủ thuật phải nhẹ nhàng tránh gây tổn thương bờ mi và giác mạc bệnh nhân.

Khi sai người/mắt, phản ứng thuốc, đau dữ dội, tổn thương hoặc diễn biến toàn thân bất thường: dừng, bảo đảm an toàn, báo bác sĩ, đánh giá và xử trí theo tình trạng. Phản vệ xử trí ngay theo Thông tư 51/2017/TT-BYT; không trì hoãn cấp cứu để hoàn tất hồ sơ.

7.2. Sau thực hiện

Theo dõi đau, đỏ mắt, chảy máu và thị lực theo kỹ thuật. Giảm thị lực, đau tăng, sợ sáng hoặc khó chịu kéo dài cần bác sĩ khám. Không chỉ băng mắt hoặc tự cho thuốc để thay khám nguyên nhân. Thuốc và băng theo y lệnh.

7.3. Theo dõi muộn

Hướng dẫn không dụi mắt, dùng thuốc đúng đơn và tái khám theo chỉ định; quay lại ngay khi đau tăng, nhìn mờ hoặc triệu chứng xấu đi. Ghi và báo cáo sự cố, đánh giá lại trước thực hiện tiếp; không khẳng định tuyệt đối “không tai biến”.

Tài liệu tham khảo

QĐ3023/QĐ-BYT ngày 28/7/2023 về đề cương. Tài liệu nguồn QTKT DD năm 2025 do bệnh viện cung cấp. QĐ3517/QĐ-BYT ngày 12/11/2025 về Mắt Tập 1: cần đối chiếu đầy đủ đúng mục kỹ thuật trước ban hành. IFU và nhãn thuốc thực tế phải được xác nhận; các nguồn an toàn tại phần đầu hỗ trợ rà soát, không thay thế chỉ định chuyên khoa.

Danh mục chuẩn bị của kỹ thuật

TT	Danh mục chuẩn bị	Đơn vị	Số lượng
1	Lao động trực tiếp		
1.1	Điều dưỡng chuyên khoa Mắt	Người	01
2	Thuốc (tên hoạt chất, nồng độ, hàm lượng, đường dùng/dạng dùng)		Theo y lệnh / nhãn
2.1	Alcain 0.5%	Chai	Theo y lệnh / nhãn
2.2	Natricorua 0,9%	Chai	01
2.3	Thuốc kháng sinh tra oflovid	Chai	Theo y lệnh / nhãn
3	Vật tư (được sử dụng trực tiếp)		
3.1	Tâm bông vô trùng	Bịt	01
3.2	Găng tay sạch	Cặp	01
4	Trang thiết bị (sử dụng trực tiếp)		
4.1	Đèn phẫu thuật	Cái	01
4.2	Máy đốt cao tần	Cái	01
4.3	Nhíp	Cái	01

Danh mục kế thừa từ nguồn để đối chiếu, phải điều chỉnh đúng thiết bị và chỉ định; không thay thế các điều kiện mục 5. Thuốc/thiết bị có thông tin chưa xác nhận thì chưa sử dụng.

M-12. QUY TRÌNH CHÍCH CHẮP, LẸO

1. ĐẠI CƯƠNG

Chích chắp - lẹo là kỹ thuật lấy đi ổ chắp hoặc lẹo.

2. CHỈ ĐỊNH

Chắp hoặc lẹo được bác sĩ đánh giá cần rạch/nạo sau cân nhắc điều trị khác; chắp không đồng nghĩa ổ mủ. Chắp tái phát cùng vị trí hoặc biểu hiện không điển hình cần xem xét bệnh phẩm loại trừ u.

3. CHỐNG CHỈ ĐỊNH

Chắp, lẹo đang sưng tấy.

Những bệnh toàn thân chưa cho phép phẫu thuật.

4. THẬN TRỌNG

Xác định đúng người và mắt/bên; đánh giá dị ứng, thuốc và khả năng phối hợp. Đau tăng hoặc giảm thị lực cần bác sĩ đánh giá. Không để phép đo/thủ thuật trì hoãn cấp cứu; tránh ép nhãn cầu khi nghi vết thương hở. Trẻ em cần cách hỗ trợ và kế hoạch vô cảm phù hợp, không cố làm khi không an toàn.

Kỹ thuật có tiếp xúc mắt hoặc xâm lấn: xác nhận năng lực, dùng dụng cụ được xử lý đúng và bảo vệ giác mạc. Không cố đưa dụng cụ qua cản trở; nếu đau/chảy máu bất thường phải dừng.

5. CHUẨN BỊ

5.1. Người thực hiện

Bác sĩ Mắt thực hiện phẫu thuật/thủ thuật; điều dưỡng chuẩn bị, phụ thủ thuật và theo dõi.

Theo phạm vi hành nghề, năng lực và phân công đã được xác nhận. Bác sĩ xác lập chỉ định; điều dưỡng chuẩn bị, hỗ trợ và theo dõi, chỉ trực tiếp thực hiện thao tác thuộc phạm vi được giao.

5.2. Thuốc

Thuốc nhỏ tê Alcain 0.5%

Thuốc rửa mắt: Col. Natricorua 0,9%

Thuốc tra mắt oflovid

Dùng theo y lệnh và đúng nhãn chế phẩm; xác nhận dị ứng, nồng độ, liều, đường dùng, mắt và hạn dùng/hạn sau mở. Không áp dụng thuốc khi kỹ thuật không cần; không dùng chế phẩm sát khuẩn da thay dung dịch dùng cho mắt.

5.3. Vật tư

Dung dịch sát khuẩn đúng chế phẩm, nồng độ và vị trí dùng theo quy trình Mắt; chế phẩm dùng ngoài da không được mặc định nhỏ/rửa bề mặt nhãn cầu.

Mâm Inox vô khuẩn đựng: Que tăm bông vô khuẩn, gạc vô khuẩn, gòn khô.

Găng tay vô khuẩn.

Bơm tiêm 1ml

Bộ dụng cụ chích chắp, lẹo.

Dao 11.

Gạc/tăm bông và dụng cụ tiếp xúc vết thương phải phù hợp vô khuẩn; vệ sinh tay, găng/bảo hộ theo nguy cơ. Mỗi mắt có vật tư làm sạch riêng; chuẩn bị hộp vật sắc nhọn khi liên quan.

5.4. Trang thiết bị

Kiểm tra hoạt động, hiệu chuẩn và IFU đúng model; khử khuẩn bề mặt dùng chung giữa người bệnh, xử lý dụng cụ tiếp xúc giác mạc theo quy trình đã xác nhận. Phương tiện cấp cứu sẵn tiếp cận.

5.5. Người bệnh

Được giải thích về mục đích và các thì của thủ thuật.

Khai thác tiền sử đông máu, tiền sử tăng huyết áp.

Giải thích, xác nhận hợp tác/đồng ý theo mức can thiệp; đánh giá bệnh nền, thuốc, dị ứng và đúng mắt cần thực hiện.

5.6. Hồ sơ bệnh án

Theo quy định của Bộ y tế.

Có chỉ định, đánh giá và thông tin cần thiết của đúng người; giấy đồng ý và hồ sơ phẫu thuật khi áp dụng.

5.7. Thời gian thực hiện kỹ thuật

Thời gian thực hiện kỹ thuật: khoảng 5 – 15 phút.

Thời gian trong nguồn chỉ là ước tính, không phải thời gian bắt buộc chờ; ghi thực tế và theo dõi theo tình trạng.

5.8. Địa điểm thực hiện kỹ thuật

Địa điểm thực hiện kỹ thuật: phòng thủ thuật.

5.9. Kiểm tra hồ sơ và người bệnh

Đối chiếu ít nhất hai định danh và đúng mắt/bên; kiểm tra chỉ định, nguy cơ, thuốc, dụng cụ, thiết bị, đồng ý và nhân lực. Dừng khi sai hoặc thiếu điều kiện, báo bác sĩ giải quyết.

6. TIẾN HÀNH QUY TRÌNH KỸ THUẬT

6.1. Xác nhận và chuẩn bị thao tác

Thực hiện kiểm tra mục 5.9, vệ sinh tay và bố trí người bệnh; các bước dưới đây thực hiện bởi người đủ phạm vi và năng lực theo phân công.

6.2. Thực hiện kỹ thuật

Hướng dẫn bệnh nhân nằm ngửa đầu trên bàn.

Điều dưỡng ngồi ở phía đỉnh đầu bệnh nhân.

Rửa sạch mắt bệnh nhân.

Thuốc tê bề mặt theo y lệnh/nhãn.

Sát khuẩn da vùng mi theo quy trình chuyên khoa, bảo vệ giác mạc; tránh để dung dịch không phù hợp vào mắt.

Chỉnh ánh sáng đúng phẫu trường.

Điều dưỡng mang khẩu trang, rửa tay, mang găng vô trùng

Chuẩn bị thuốc tê tiêm theo y lệnh, xác nhận nồng độ, thể tích, tổng liều và dị ứng; không dùng một thể tích chung cho mọi kích thước/tuổi.

Thử kim

Hướng dẫn bệnh nhân liếc mắt lên trên, hoặc xuống dưới tùy theo vị trí chắp, mi dưới thì liếc lên, mi trên thì liếc mắt xuống.

Bác sĩ gây tê tại chỗ theo giải phẫu và liều đã xác nhận; theo dõi tác dụng tại chỗ/toàn thân.

Dùng gòn ấn nhẹ lên chổ rút kim.

Dùng kẹp chắp cố định và bộc lộ ổ chắp.

Chú ý:

Bác sĩ chọn đường rạch, giải phóng/nạo tổn thương phù hợp từ phía kết mạc hoặc da; bảo vệ cấu trúc mi và nhãn cầu. Điều dưỡng cung cấp dụng cụ, theo dõi và ghi nhận.

Nếu ổ chắp ở ngoài da mi.

Dùng dao 11 rạch da song song với bờ mi.

Dùng Curette nạo sạch mủ, chất nhày ổ chắp lẹo

Nếu chắp có ổ bọc, ta dùng pince và kéo cong nhỏ lấy trọn khối ổ chắp.

Cầm máu theo đánh giá bác sĩ tại vùng can thiệp; không đè mạnh lên nhãn cầu.

Làm sạch bằng dung dịch phù hợp dùng cho mắt theo quy trình/y lệnh, không mặc định rửa mắt bằng povidone-iodine 5%.

Rửa lại mắt bằng Natriclorua 0,9%

Dùng kháng sinh tại chỗ khi có y lệnh, đúng chế phẩm và liều.

Không tự phối hợp thêm thuốc mỡ kháng sinh nếu chưa có y lệnh.

Băng và thời điểm tháo theo y lệnh, đánh giá chảy máu và tình trạng mắt; không áp dụng chung 2–3 giờ.

Thu dọnn dụng cụ, rửa tay.

Ghi hồ sơ.

6.3. Kết thúc và bàn giao

Đánh giá mắt và tình trạng người bệnh, ghi kết quả/thuốc/thao tác, diễn biến, giờ và người thực hiện; báo bác sĩ bất thường. Thu dọn, xử lý dụng cụ và chất thải đúng quy định; hướng dẫn chăm sóc và lịch khám, bàn giao khi chuyển.

7. THEO DÕI VÀ XỬ TRÍ TAI BIẾN

7.1. Trong thực hiện

Chảy máu: báo bác sĩ, kiểm tra cầm máu và mức tổn thương; băng theo chỉ định, không băng ép mọi trường hợp.

Nghi nhiễm khuẩn: bác sĩ khám, quyết định thuốc theo mức độ; không mặc định kháng sinh toàn thân.

Khi sai người/mắt, phản ứng thuốc, đau dữ dội, tổn thương hoặc diễn biến toàn thân bất thường: dừng, bảo đảm an toàn, báo bác sĩ, đánh giá và xử trí theo tình trạng. Phản vệ xử trí ngay theo Thông tư 51/2017/TT-BYT; không trì hoãn cấp cứu để hoàn tất hồ sơ.

7.2. Sau thực hiện

Theo dõi đau, đỏ mắt, chảy máu và thị lực theo kỹ thuật. Giảm thị lực, đau tăng, sợ sáng hoặc khó chịu kéo dài cần bác sĩ khám. Không chỉ băng mắt hoặc tự cho thuốc để thay khám nguyên nhân. Thuốc và băng theo y lệnh.

7.3. Theo dõi muộn

Hướng dẫn không dụi mắt, dùng thuốc đúng đơn và tái khám theo chỉ định; quay lại ngay khi đau tăng, nhìn mờ hoặc triệu chứng xấu đi. Ghi và báo cáo sự cố, đánh giá lại trước thực hiện tiếp; không khẳng định tuyệt đối “không tai biến”.

Tài liệu tham khảo

QĐ3023/QĐ-BYT ngày 28/7/2023 về đề cương. Tài liệu nguồn QTKT DD năm 2025 do bệnh viện cung cấp. QĐ3517/QĐ-BYT ngày 12/11/2025 về Mắt Tập 1: cần đối chiếu đầy đủ đúng mục kỹ thuật trước ban hành. IFU và nhãn thuốc thực tế phải được xác nhận; các nguồn an toàn tại phần đầu hỗ trợ rà soát, không thay thế chỉ định chuyên khoa.

Danh mục chuẩn bị của kỹ thuật

TT	Danh mục chuẩn bị	Đơn vị	Số lượng
1	Lao động trực tiếp		
1.1	Điều dưỡng chuyên khoa Mắt	Người	02
2	Thuốc (tên hoạt chất, nồng độ, hàm lượng, đường dùng/dạng dùng)		Theo y lệnh / nhãn
2.1	Alcain 0.5%	Chai	Theo y lệnh / nhãn
2.2	Natricorua 0,9%	Chai	01
2.3	Thuốc kháng sinh tra oflovid	Chai	Theo y lệnh / nhãn
2.4	Povidine 10%	Chai	Theo y lệnh / nhãn

TT	Danh mục chuẩn bị	Đơn vị	Số lượng
3	Vật tư (được sử dụng trực tiếp)		
3.1	Tâm bông vô trùng	Bịt	01
3.2	Gạc vô khuẩn	Miếng	01
3.3	Găng tay sạch	Cặp	01
4	Trang thiết bị (sử dụng trực tiếp)		
4.1	Đèn phẫu thuật	Cái	01
4.2	Bộ dụng cụ chích chắp, lẹo	Bộ	01

Danh mục kế thừa từ nguồn để đối chiếu, phải điều chỉnh đúng thiết bị và chỉ định; không thay thế các điều kiện mục 5. Thuốc/thiết bị có thông tin chưa xác nhận thì chưa sử dụng.

M-13. QUY TRÌNH CẮT CHỈ KHÂU KẾT MẠC

1. ĐẠI CƯƠNG

Cắt chỉ khâu kết mạc đúng thời điểm giúp cho kết mạc liền tốt,làm giảm

cảm giác cộm,đau của người bệnh

2. CHỈ ĐỊNH

Chỉ kết mạc được bác sĩ xác nhận có thể cắt theo tình trạng liền thương và loại phẫu thuật; không tự cắt chỉ chỉ dựa thời gian.

3. CHỐNG CHỈ ĐỊNH

Người bệnh không hợp tác, bệnh nhân có những bệnh toàn thân không cho phép.

4. THẬN TRỌNG

Xác định đúng người và mắt/bên; đánh giá dị ứng, thuốc và khả năng phối hợp. Đau tăng hoặc giảm thị lực cần bác sĩ đánh giá. Không để phép đo/thủ thuật trì hoãn cấp cứu; tránh ép nhãn cầu khi nghi vết thương hở. Trẻ em cần cách hỗ trợ và kế hoạch vô cảm phù hợp, không cố làm khi không an toàn.

Kỹ thuật có tiếp xúc mắt hoặc xâm lấn: xác nhận năng lực, dùng dụng cụ được xử lý đúng và bảo vệ giác mạc. Không cố đưa dụng cụ qua cản trở; nếu đau/chảy máu bất thường phải dừng.

5. CHUẨN BỊ

5.1. Người thực hiện

Người thực hiện: Điều dưỡng chuyên khoa Mắt.

Theo phạm vi hành nghề, năng lực và phân công đã được xác nhận. Bác sĩ xác lập chỉ định; điều dưỡng chuẩn bị, hỗ trợ và theo dõi, chỉ trực tiếp thực hiện thao tác thuộc phạm vi được giao.

5.2. Thuốc

Thuốc nhỏ tê Alcain 0.5%

Thuốc rửa mắt: Col. Natricorua 0,9%

Povidine 5%

Thuốc nhỏ kháng sinh

Dùng theo y lệnh và đúng nhãn chế phẩm; xác nhận dị ứng, nồng độ, liều, đường dùng, mắt và hạn dùng/hạn sau mở. Không áp dụng thuốc khi kỹ thuật không cần; không dùng chế phẩm sát khuẩn da thay dung dịch dùng cho mắt.

5.3. Vật tư

Mâm Inox vô khuẩn đựng: Gạc vô khuẩn, que tăm bông vô khuẩn, nhíp vô khuẩn không mấu, Bình kiềm

Găng tay sạch.

Dao 11.

Gạc/tăm bông và dụng cụ tiếp xúc vết thương phải phù hợp vô khuẩn; vệ sinh tay, găng/bảo hộ theo nguy cơ. Mỗi mắt có vật tư làm sạch riêng; chuẩn bị hộp vật sắc nhọn khi liên quan.

5.4. Trang thiết bị

Kiểm tra hoạt động, hiệu chuẩn và IFU đúng model; khử khuẩn bề mặt dùng chung giữa người bệnh, xử lý dụng cụ tiếp xúc giác mạc theo quy trình đã xác nhận. Phương tiện cấp cứu sẵn tiếp cận.

5.5. Người bệnh

Được giải thích về mục đích và các thì của thủ thuật.

Giải thích, xác nhận hợp tác/đồng ý theo mức can thiệp; đánh giá bệnh nền, thuốc, dị ứng và đúng mắt cần thực hiện.

5.6. Hồ sơ bệnh án

Theo quy định của Bộ y tế.

Có chỉ định, đánh giá và thông tin cần thiết của đúng người; giấy đồng ý và hồ sơ phẫu thuật khi áp dụng.

5.7. Thời gian thực hiện kỹ thuật

Thời gian thực hiện kỹ thuật: khoảng 5 – 10 phút.

Thời gian trong nguồn chỉ là ước tính, không phải thời gian bắt buộc chờ; ghi thực tế và theo dõi theo tình trạng.

5.8. Địa điểm thực hiện kỹ thuật

Địa điểm thực hiện kỹ thuật: phòng thủ thuật.

5.9. Kiểm tra hồ sơ và người bệnh

Đối chiếu ít nhất hai định danh và đúng mắt/bên; kiểm tra chỉ định, nguy cơ, thuốc, dụng cụ, thiết bị, đồng ý và nhân lực. Dừng khi sai hoặc thiếu điều kiện, báo bác sĩ giải quyết.

6. TIẾN HÀNH QUY TRÌNH KỸ THUẬT

6.1. Xác nhận và chuẩn bị thao tác

Thực hiện kiểm tra mục 5.9, vệ sinh tay và bố trí người bệnh; các bước dưới đây thực hiện bởi người đủ phạm vi và năng lực theo phân công.

6.2. Thực hiện kỹ thuật

Hướng dẫn bệnh nhân nằm ngửa đầu bằng hoặc kê gối thấp.

Điều dưỡng ngồi ở phía đỉnh đầu bệnh nhân.

Thuốc tê bề mặt theo y lệnh và nhãn.

Điều dưỡng mang khẩu trang, rửa tay, mang găng

Đặt vành mi

Người đủ năng lực dùng dụng cụ cắt chỉ nhãn khoa vô khuẩn phù hợp, cắt tránh kết mạc/giác mạc; bảo vệ mắt và không áp dụng dao số 11 cho mọi loại chỉ.

Dùng nhíp không mấu kẹp và rút chỉ ra.

Kiểm tra đã lấy đúng phần chỉ cần lấy, vết thương không hở; dùng thuốc sau thủ thuật theo y lệnh, không gây tê lại mặc định.

Thu dọnn dụng cụ, rửa tay.

Ghi hồ sơ.

6.3. Kết thúc và bàn giao

Đánh giá mắt và tình trạng người bệnh, ghi kết quả/thuốc/thao tác, diễn biến, giờ và người thực hiện; báo bác sĩ bất thường. Thu dọn, xử lý dụng cụ và chất thải đúng quy định; hướng dẫn chăm sóc và lịch khám, bàn giao khi chuyển.

7. THEO DÕI VÀ XỬ TRÍ TAI BIẾN

7.1. Trong thực hiện

Chảy máu hoặc hở vết khâu: dừng, báo bác sĩ khám và xử trí, không tiếp tục cắt các chỉ khác khi chưa xác nhận.

Đau, giảm thị lực hoặc nghi trợt giác mạc: khám chuyên khoa và thuốc theo y lệnh, không tự kê điều trị.

Khi sai người/mắt, phản ứng thuốc, đau dữ dội, tổn thương hoặc diễn biến toàn thân bất thường: dừng, bảo đảm an toàn, báo bác sĩ, đánh giá và xử trí theo tình trạng. Phản vệ xử trí ngay theo Thông tư 51/2017/TT-BYT; không trì hoãn cấp cứu để hoàn tất hồ sơ.

7.2. Sau thực hiện

Theo dõi đau, đỏ mắt, chảy máu và thị lực theo kỹ thuật. Giảm thị lực, đau tăng, sợ sáng hoặc khó chịu kéo dài cần bác sĩ khám. Không chỉ băng mắt hoặc tự cho thuốc để thay khám nguyên nhân. Thuốc và băng theo y lệnh.

7.3. Theo dõi muộn

Hướng dẫn không dụi mắt, dùng thuốc đúng đơn và tái khám theo chỉ định; quay lại ngay khi đau tăng, nhìn mờ hoặc triệu chứng xấu đi. Ghi và báo cáo sự cố, đánh giá lại trước thực hiện tiếp; không khẳng định tuyệt đối “không tai biến”.

Tài liệu tham khảo

QĐ3023/QĐ-BYT ngày 28/7/2023 về đề cương. Tài liệu nguồn QTKT DD năm 2025 do bệnh viện cung cấp. QĐ3517/QĐ-BYT ngày 12/11/2025 về Mắt Tập 1: cần đối chiếu đầy đủ đúng mục kỹ thuật trước ban hành. IFU và nhãn thuốc thực tế phải được xác nhận; các nguồn an toàn tại phần đầu hỗ trợ rà soát, không thay thế chỉ định chuyên khoa.

Danh mục chuẩn bị của kỹ thuật

TT	Danh mục chuẩn bị	Đơn vị	Số lượng
1	Lao động trực tiếp		
1.1	Điều dưỡng chuyên khoa Mắt	Người	01

TT	Danh mục chuẩn bị	Đơn vị	Số lượng
2	Thuốc (tên hoạt chất, nồng độ, hàm lượng, đường dùng/dạng dùng)		Theo y lệnh / nhãn
2.1	Alcain 0.5%	Chai	Theo y lệnh / nhãn
2.2	Natricorua 0,9%	Chai	01
2.3	Thuốc kháng sinh nhỏ	Chai	Theo y lệnh / nhãn
2.4	Povidine 5%	Chai	Theo y lệnh / nhãn
3	Vật tư (được sử dụng trực tiếp)		
3.1	Tâm bông vô trùng	Bịt	01
3.2	Gạc vô khuẩn	Miếng	01
3.3	Găng tay sạch	Cặp	01
4	Trang thiết bị (sử dụng trực tiếp)		
4.1	Sinh hiển vi	Cái	01
4.2	Dao 11	Bộ	01

Danh mục kế thừa từ nguồn để đối chiếu, phải điều chỉnh đúng thiết bị và chỉ định; không thay thế các điều kiện mục 5. Thuốc/thiết bị có thông tin chưa xác nhận thì chưa sử dụng.

M-14. QUY TRÌNH ĐO NHÃN ÁP BẰNG NHÃN ÁP KẾ SCHIOTZ

1. ĐẠI CƯƠNG

Xác định áp lực trong nhãn cầu, để theo dõi, chẩn đoán và điều trị các bệnh liên quan đến nhãn áp như: Glaucoma, chấn thương,…

2. CHỈ ĐỊNH

Người bệnh có chỉ định đánh giá/theo dõi nhãn áp và phù hợp phương pháp Schiotz; không lấy tuổi từ 35 làm chỉ định bắt buộc cho mọi người.

Người trẻ tuổi có những dấu hiệu nghi ngờ Glaucoma

Người bệnh có yếu tố gia đình đã có người ruột thịt từng bị Glaucoma

3. CHỐNG CHỈ ĐỊNH

Người bệnh có viêm nhiễm cấp tính tại mắt

Giác mạc đã có tổn thương

Mắt bị chấn thương có vết thương hở

4. THẬN TRỌNG

Xác định đúng người và mắt/bên; đánh giá dị ứng, thuốc và khả năng phối hợp. Đau tăng hoặc giảm thị lực cần bác sĩ đánh giá. Không để phép đo/thủ thuật trì hoãn cấp cứu; tránh ép nhãn cầu khi nghi vết thương hở. Trẻ em cần cách hỗ trợ và kế hoạch vô cảm phù hợp, không cố làm khi không an toàn.

Kỹ thuật có tiếp xúc mắt hoặc xâm lấn: xác nhận năng lực, dùng dụng cụ được xử lý đúng và bảo vệ giác mạc. Không cố đưa dụng cụ qua cản trở; nếu đau/chảy máu bất thường phải dừng.

5. CHUẨN BỊ

5.1. Người thực hiện

Người thực hiện: Điều dưỡng chuyên khoa Mắt.

Theo phạm vi hành nghề, năng lực và phân công đã được xác nhận. Bác sĩ xác lập chỉ định; điều dưỡng chuẩn bị, hỗ trợ và theo dõi, chỉ trực tiếp thực hiện thao tác thuộc phạm vi được giao.

5.2. Thuốc

Thuốc nhỏ tê Alcain 0.5%

Dùng theo y lệnh và đúng nhãn chế phẩm; xác nhận dị ứng, nồng độ, liều, đường dùng, mắt và hạn dùng/hạn sau mở. Không áp dụng thuốc khi kỹ thuật không cần; không dùng chế phẩm sát khuẩn da thay dung dịch dùng cho mắt.

5.3. Vật tư

Gòn khô.

Dung dịch sát khuẩn tay nhanh.

Gạc/tăm bông và dụng cụ tiếp xúc vết thương phải phù hợp vô khuẩn; vệ sinh tay, găng/bảo hộ theo nguy cơ. Mỗi mắt có vật tư làm sạch riêng; chuẩn bị hộp vật sắc nhọn khi liên quan.

5.4. Trang thiết bị

Bộ nhãn áp kế Schiotz, quả cân và bảng quy đổi đúng thiết bị theo hướng dẫn; kiểm tra hiệu chuẩn và tình trạng trước sử dụng.

Kiểm tra hoạt động, hiệu chuẩn và IFU đúng model; khử khuẩn bề mặt dùng chung giữa người bệnh, xử lý dụng cụ tiếp xúc giác mạc theo quy trình đã xác nhận. Phương tiện cấp cứu sẵn tiếp cận.

5.5. Người bệnh

Được giải thích về mục đích và các thì của thủ thuật.

Giải thích, xác nhận hợp tác/đồng ý theo mức can thiệp; đánh giá bệnh nền, thuốc, dị ứng và đúng mắt cần thực hiện.

5.6. Hồ sơ bệnh án

Theo quy định của Bộ y tế.

Có chỉ định, đánh giá và thông tin cần thiết của đúng người; giấy đồng ý và hồ sơ phẫu thuật khi áp dụng.

5.7. Thời gian thực hiện kỹ thuật

Thời gian thực hiện kỹ thuật: khoảng 3 – 7 phút.

Thời gian trong nguồn chỉ là ước tính, không phải thời gian bắt buộc chờ; ghi thực tế và theo dõi theo tình trạng.

5.8. Địa điểm thực hiện kỹ thuật

Địa điểm thực hiện kỹ thuật: phòng thủ thuật.

5.9. Kiểm tra hồ sơ và người bệnh

Đối chiếu ít nhất hai định danh và đúng mắt/bên; kiểm tra chỉ định, nguy cơ, thuốc, dụng cụ, thiết bị, đồng ý và nhân lực. Dừng khi sai hoặc thiếu điều kiện, báo bác sĩ giải quyết.

6. TIẾN HÀNH QUY TRÌNH KỸ THUẬT

6.1. Xác nhận và chuẩn bị thao tác

Thực hiện kiểm tra mục 5.9, vệ sinh tay và bố trí người bệnh; các bước dưới đây thực hiện bởi người đủ phạm vi và năng lực theo phân công.

6.2. Thực hiện kỹ thuật

Điều dưỡng rửa tay, mang khẩu trang

Hướng dẫn bệnh nhân nằm ngửa đầu bằng hoặc kê gối thấp.

Điều dưỡng ngồi ở phía đỉnh đầu bệnh nhân.

Thuốc tê theo đúng y lệnh/nhãn, xác nhận hiệu lực trước đo.

Dùng quả cân có trọng lượng 5,5g. nếu nhãn áp cao thì dùng quả cân có trọng lượng lớn hơn.

Kiểm tra điểm 0, độ di động và tình trạng nhãn áp kế theo hướng dẫn. Nếu sai chuẩn hoặc kẹt, ngừng dùng và chuyển xử lý/bảo trì; không tự tháo sửa khi chưa được phép.

Làm sạch và xử lý tái sử dụng bộ phận tiếp xúc giác mạc theo IFU và quy trình kiểm soát nhiễm khuẩn đã được xác nhận; đủ nồng độ/thời gian, tráng và làm khô khi yêu cầu. Không coi lau cồn 90° rồi lau khô là quy trình khử khuẩn đủ cho mọi máy; không để tồn dư hóa chất tiếp xúc giác mạc.

Cố định mắt bệnh nhân: Hướng dẫn bệnh nhân nhìn thẳng vào đầu ngón tay trỏ (tránh đảo mắt lúc đo), điều chỉnh ngón tay sao cho giác mạc nằm ngang ở chính giữa khe mi.

Tay trái điều dưỡng vạch rộng vành mi bệnh nhân (lưu ý không đè mạnh lên nhãn cầu)

Tay phải cầm nhãn áp kế, xoay xoay mặt kim số nhãn áp theo hướng quan sát và đặt nhãn áp kế thẳng góc lên giác mạc.

Hạ dần tay cầm xuống 2/3 chiều cao nòng nhãn áp kế.

Đọc thang và lựa chọn thay quả cân theo đúng hướng dẫn máy khi cần; rút dụng cụ nhẹ, tránh trượt trên giác mạc.

Quy đổi bằng bảng đúng quả cân và thiết bị; ghi mắt, số đọc, quả cân, kết quả mmHg, thời điểm, người thực hiện và giới hạn phép đo. Báo bác sĩ kết quả bất thường hoặc không tin cậy.

Rửa lại mắt bệnh nhân.

Không dụi mắt khi còn tác dụng tê; báo ngay đau tăng, đỏ hoặc nhìn mờ sau đo.

Thu dọnn dụng cụ

Ghi hồ sơ.

6.3. Kết thúc và bàn giao

Đánh giá mắt và tình trạng người bệnh, ghi kết quả/thuốc/thao tác, diễn biến, giờ và người thực hiện; báo bác sĩ bất thường. Thu dọn, xử lý dụng cụ và chất thải đúng quy định; hướng dẫn chăm sóc và lịch khám, bàn giao khi chuyển.

7. THEO DÕI VÀ XỬ TRÍ TAI BIẾN

7.1. Trong thực hiện

- Tổn thương biểu mô giác mạc.

Khi sai người/mắt, phản ứng thuốc, đau dữ dội, tổn thương hoặc diễn biến toàn thân bất thường: dừng, bảo đảm an toàn, báo bác sĩ, đánh giá và xử trí theo tình trạng. Phản vệ xử trí ngay theo Thông tư 51/2017/TT-BYT; không trì hoãn cấp cứu để hoàn tất hồ sơ.

7.2. Sau thực hiện

Theo dõi đau, đỏ mắt, chảy máu và thị lực theo kỹ thuật. Giảm thị lực, đau tăng, sợ sáng hoặc khó chịu kéo dài cần bác sĩ khám. Không chỉ băng mắt hoặc tự cho thuốc để thay khám nguyên nhân. Thuốc và băng theo y lệnh.

7.3. Theo dõi muộn

Hướng dẫn không dụi mắt, dùng thuốc đúng đơn và tái khám theo chỉ định; quay lại ngay khi đau tăng, nhìn mờ hoặc triệu chứng xấu đi. Ghi và báo cáo sự cố, đánh giá lại trước thực hiện tiếp; không khẳng định tuyệt đối “không tai biến”.

Tài liệu tham khảo

QĐ3023/QĐ-BYT ngày 28/7/2023 về đề cương. Tài liệu nguồn QTKT DD năm 2025 do bệnh viện cung cấp. QĐ3517/QĐ-BYT ngày 12/11/2025 về Mắt Tập 1: cần đối chiếu đầy đủ đúng mục kỹ thuật trước ban hành. IFU và nhãn thuốc thực tế phải được xác nhận; các nguồn an toàn tại phần đầu hỗ trợ rà soát, không thay thế chỉ định chuyên khoa.

Danh mục chuẩn bị của kỹ thuật

TT	Danh mục chuẩn bị	Đơn vị	Số lượng
1	Lao động trực tiếp		
1.1	Điều dưỡng chuyên khoa Mắt	Người	01
2	Thuốc (tên hoạt chất, nồng độ, hàm lượng, đường dùng/dạng dùng)		Theo y lệnh / nhãn
2.1	Alcain 0.5%	Chai	Theo y lệnh / nhãn
2.2	Natricorua 0,9%	Chai	01
3	Vật tư (được sử dụng trực tiếp)		
3.1	Gòn khô	Bịt	01
4	Trang thiết bị (sử dụng trực tiếp)		
4.1	Bộ nhãn áp kế schiotz	Cái	01

Danh mục kế thừa từ nguồn để đối chiếu, phải điều chỉnh đúng thiết bị và chỉ định; không thay thế các điều kiện mục 5. Thuốc/thiết bị có thông tin chưa xác nhận thì chưa sử dụng.

M-15. QUY TRÌNH KỸ THUẬT PHỤ MỔ MỌNG THỊT

1. ĐẠI CƯƠNG

Hỗ trợ bác sĩ làm phẫu thuật cắt mộng thịt chính xác, nhẹ nhàng.

2. CHỈ ĐỊNH

Người bệnh có chỉ định phẫu thuật mộng thịt do bác sĩ xác lập; điều dưỡng phụ mổ theo kế hoạch phẫu thuật, không chỉ dựa phân độ để tự chỉ định.

3. CHỐNG CHỈ ĐỊNH

Người bệnh có viêm nhiễm cấp tính tại mắt như: Viêm kết mạc, viêm giác mạc, loét giác mạc, viêm màng bồ đào,..

Người bệnh không hợp tác.

4. THẬN TRỌNG

Xác định đúng người và mắt/bên; đánh giá dị ứng, thuốc và khả năng phối hợp. Đau tăng hoặc giảm thị lực cần bác sĩ đánh giá. Không để phép đo/thủ thuật trì hoãn cấp cứu; tránh ép nhãn cầu khi nghi vết thương hở. Trẻ em cần cách hỗ trợ và kế hoạch vô cảm phù hợp, không cố làm khi không an toàn.

Phụ mổ không thay thế quy trình phẫu thuật của bác sĩ; hoàn tất bảng kiểm an toàn phẫu thuật, kiểm đếm, quản lý thuốc, bệnh phẩm và bàn giao.

5. CHUẨN BỊ

5.1. Người thực hiện

Người thực hiện: Điều dưỡng chuyên khoa Mắt.

Theo phạm vi hành nghề, năng lực và phân công đã được xác nhận. Bác sĩ xác lập chỉ định; điều dưỡng chuẩn bị, hỗ trợ và theo dõi, chỉ trực tiếp thực hiện thao tác thuộc phạm vi được giao.

5.2. Thuốc

Thuốc: Thuốc nhỏ tê Alcain 0.5%.Povidine 5%.Povidine 10%. Medicain 2%. Col. Vigamox 0,5%. Pd. Oflovid 0,3% Dung dịch rửa mắt Natriclorid 0,9%

Dùng theo y lệnh và đúng nhãn chế phẩm; xác nhận dị ứng, nồng độ, liều, đường dùng, mắt và hạn dùng/hạn sau mở. Không áp dụng thuốc khi kỹ thuật không cần; không dùng chế phẩm sát khuẩn da thay dung dịch dùng cho mắt.

5.3. Vật tư

Dụng cụ:

Dụng cụ vô khuẩn: Găng vô trùng, bơm tiêm 3ml, bơm tiêm 5ml, kim đầu tù, hộp gòn, tăm bông (đã hấp vô khuẩn),vành mi, cán dao số 15,dao số 15, kẹp kết mạc có mấu, không mấu, kẹp mang kim,kéo cong cắt chỉ kéo kết mạc, móc lác, chỉ Vicryl 7/0 hoặc 8/0.Khăn lỗ, bình kiềm.

Gạc/tăm bông và dụng cụ tiếp xúc vết thương phải phù hợp vô khuẩn; vệ sinh tay, găng/bảo hộ theo nguy cơ. Mỗi mắt có vật tư làm sạch riêng; chuẩn bị hộp vật sắc nhọn khi liên quan.

5.4. Trang thiết bị

Máy sinh hiển vi phẫu thuật và thiết bị theo kế hoạch; bỏ đèn cồn khỏi trường mổ, không dùng lửa để xử lý dụng cụ thay tiệt khuẩn.

Kiểm tra hoạt động, hiệu chuẩn và IFU đúng model; khử khuẩn bề mặt dùng chung giữa người bệnh, xử lý dụng cụ tiếp xúc giác mạc theo quy trình đã xác nhận. Phương tiện cấp cứu sẵn tiếp cận.

5.5. Người bệnh

Được giải thích về mục đích và các thì của thủ thuật.

Giải thích, xác nhận hợp tác/đồng ý theo mức can thiệp; đánh giá bệnh nền, thuốc, dị ứng và đúng mắt cần thực hiện.

5.6. Hồ sơ bệnh án

Theo quy định của Bộ y tế.

Có chỉ định, đánh giá và thông tin cần thiết của đúng người; giấy đồng ý và hồ sơ phẫu thuật khi áp dụng.

5.7. Thời gian thực hiện kỹ thuật

Thời gian thực hiện kỹ thuật: khoảng 10 – 30 phút.

Thời gian trong nguồn chỉ là ước tính, không phải thời gian bắt buộc chờ; ghi thực tế và theo dõi theo tình trạng.

5.8. Địa điểm thực hiện kỹ thuật

Địa điểm thực hiện kỹ thuật: phòng phẫu thuật.

5.9. Kiểm tra hồ sơ và người bệnh

Đối chiếu ít nhất hai định danh và đúng mắt/bên; kiểm tra chỉ định, nguy cơ, thuốc, dụng cụ, thiết bị, đồng ý và nhân lực. Dừng khi sai hoặc thiếu điều kiện, báo bác sĩ giải quyết.

6. TIẾN HÀNH QUY TRÌNH KỸ THUẬT

6.1. Bước 1

Kiểm tra trước gây tê/gây mê: đúng người, thủ thuật, mắt/bên, đồng ý, thuốc/dị ứng và thiết bị; kiểm đếm dụng cụ, kim, gạc ban đầu.

6.2. Bước 2

Vệ sinh tay ngoại khoa, trang phục/găng vô khuẩn; mở và bố trí dụng cụ theo các thì của đúng phẫu thuật. Thuốc trên bàn phải có nhãn và đối chiếu khi giao.

6.3. Bước 3

Tạm dừng trước rạch: cả ê-kíp xác nhận kế hoạch, bên mổ, nguy cơ, vô khuẩn và các yêu cầu đặc biệt.

6.4. Bước 4

Phụ mổ theo từng thì phẫu thuật do bác sĩ thực hiện: đưa dụng cụ, giữ trường, hỗ trợ hút/rửa và kiểm soát chảy máu theo yêu cầu; không tự thay kỹ thuật phẫu thuật.

6.5. Bước 5

Trước đóng/kết thúc: kiểm đếm lại; xác nhận thuốc, bệnh phẩm nếu có, băng và kế hoạch sau mổ. Khi thiếu dụng cụ/gạc phải báo ngay, thực hiện quy trình xử lý sai lệch.

6.6. Bước 6

Bàn giao sang theo dõi: phẫu thuật/mắt, phương pháp vô cảm, thuốc/liều, diễn biến, băng, y lệnh và dấu hiệu cần báo; ghi người nhận và thời điểm.

7. THEO DÕI VÀ XỬ TRÍ TAI BIẾN

7.1. Trong thực hiện

Chảy máu hoặc diễn biến bất thường: báo phẫu thuật viên, hỗ trợ cầm máu/điều trị theo chỉ định và theo dõi; không chỉ băng rồi kết thúc.

Khi sai người/mắt, phản ứng thuốc, đau dữ dội, tổn thương hoặc diễn biến toàn thân bất thường: dừng, bảo đảm an toàn, báo bác sĩ, đánh giá và xử trí theo tình trạng. Phản vệ xử trí ngay theo Thông tư 51/2017/TT-BYT; không trì hoãn cấp cứu để hoàn tất hồ sơ.

7.2. Sau thực hiện

Theo dõi đau, đỏ mắt, chảy máu và thị lực theo kỹ thuật. Giảm thị lực, đau tăng, sợ sáng hoặc khó chịu kéo dài cần bác sĩ khám. Không chỉ băng mắt hoặc tự cho thuốc để thay khám nguyên nhân. Thuốc và băng theo y lệnh.

7.3. Theo dõi muộn

Hướng dẫn không dụi mắt, dùng thuốc đúng đơn và tái khám theo chỉ định; quay lại ngay khi đau tăng, nhìn mờ hoặc triệu chứng xấu đi. Ghi và báo cáo sự cố, đánh giá lại trước thực hiện tiếp; không khẳng định tuyệt đối “không tai biến”.

Tài liệu tham khảo

QĐ3023/QĐ-BYT ngày 28/7/2023 về đề cương. Tài liệu nguồn QTKT DD năm 2025 do bệnh viện cung cấp. QĐ3517/QĐ-BYT ngày 12/11/2025 về Mắt Tập 1: cần đối chiếu đầy đủ đúng mục kỹ thuật trước ban hành. IFU và nhãn thuốc thực tế phải được xác nhận; các nguồn an toàn tại phần đầu hỗ trợ rà soát, không thay thế chỉ định chuyên khoa.

Danh mục chuẩn bị của kỹ thuật

TT	Danh mục chuẩn bị	Đơn vị	Số lượng
1	Lao động trực tiếp		
1.1	Điều dưỡng chuyên khoa Mắt	Người	01
2	Thuốc (tên hoạt chất, nồng độ, hàm lượng, đường dùng/dạng dùng)		Theo y lệnh / nhãn
2.1	Alcain 0.5%	Chai	Theo y lệnh / nhãn

TT	Danh mục chuẩn bị	Đơn vị	Số lượng
2.2	Natricorua 0,9%	Chai	01
2.3	Thuốc kháng sinh tra oflovid	Chai	Theo y lệnh / nhãn
2.4	Povidine 10%, povidine 5%	Chai	Theo y lệnh / nhãn
3	Vật tư (được sử dụng trực tiếp)		
3.1	Tâm bông vô trùng	Bịt	01
3.2	Gạc vô khuẩn	Miếng	01
3.3	Găng tay vô khuẩn	Cặp	01
4	Trang thiết bị (sử dụng trực tiếp)		
4.1	Sinh hiển vi	Cái	01
4.2	Bộ dụng cụ phẫu thuật mộng	Bộ	01

Danh mục kế thừa từ nguồn để đối chiếu, phải điều chỉnh đúng thiết bị và chỉ định; không thay thế các điều kiện mục 5. Thuốc/thiết bị có thông tin chưa xác nhận thì chưa sử dụng.

M-16. QUY TRÌNH KỸ THUẬT PHỤ MỔ QUẶM

1. ĐẠI CƯƠNG

Hỗ trợ bác sĩ làm phẫu thuật quặm chính xác, nhẹ nhàng.

2. CHỈ ĐỊNH

Người bệnh quặm mi bẩm sinh, quặm tuổi già.

3. CHỐNG CHỈ ĐỊNH

Nhiễm khuẩn tại mắt, bệnh toàn thân không cho phép.

4. THẬN TRỌNG

Xác định đúng người và mắt/bên; đánh giá dị ứng, thuốc và khả năng phối hợp. Đau tăng hoặc giảm thị lực cần bác sĩ đánh giá. Không để phép đo/thủ thuật trì hoãn cấp cứu; tránh ép nhãn cầu khi nghi vết thương hở. Trẻ em cần cách hỗ trợ và kế hoạch vô cảm phù hợp, không cố làm khi không an toàn.

Phụ mổ không thay thế quy trình phẫu thuật của bác sĩ; hoàn tất bảng kiểm an toàn phẫu thuật, kiểm đếm, quản lý thuốc, bệnh phẩm và bàn giao.

5. CHUẨN BỊ

5.1. Người thực hiện

Người thực hiện: Điều dưỡng chuyên khoa Mắt.

Theo phạm vi hành nghề, năng lực và phân công đã được xác nhận. Bác sĩ xác lập chỉ định; điều dưỡng chuẩn bị, hỗ trợ và theo dõi, chỉ trực tiếp thực hiện thao tác thuộc phạm vi được giao.

5.2. Thuốc

Thuốc Thuốc nhỏ tê Alcain 0.5%. Povidine 5% . Povidine 10% . Medicain 2% . Col. Vigamox 0,5% . Pd. Oflovid 0,3% . Dung dịch rửa mắt Natriclorid 0,9%

Dùng theo y lệnh và đúng nhãn chế phẩm; xác nhận dị ứng, nồng độ, liều, đường dùng, mắt và hạn dùng/hạn sau mở. Không áp dụng thuốc khi kỹ thuật không cần; không dùng chế phẩm sát khuẩn da thay dung dịch dùng cho mắt.

5.3. Vật tư

Thiết bị theo kế hoạch mổ và phương tiện cấp cứu; không sử dụng đèn cồn trong trường mổ.

Dụng cụ vô khuẩn: Găng vô trùng (02 đôi). Bơm tiêm 3ml, bơm tiêm 5ml, kim đầu tù (mỗi loại 01).Hộp gòn, gạc, tăm bông (đã hấp vô khuẩn) (01 hộp). Bình kiềm (01 cái). Cán dao số 15 (01 cái). Dao số 15(01 cái). Thanh đè mổ quặm (01 cái). Móc lác(01 cái). Kẹp kết mạc có mấu, không mấu (02 cái). Kẹp mang kim (01 cái). Kéo cong cắt chỉ (0 cái. Kéo kết mạc (01 cái). Bồ cào (02 cái) Chỉ Vicryl 5/0 (01 cái. Chỉ Silk 6/0(01 sợi). Khăn lỗ (01 cái)

Gạc/tăm bông và dụng cụ tiếp xúc vết thương phải phù hợp vô khuẩn; vệ sinh tay, găng/bảo hộ theo nguy cơ. Mỗi mắt có vật tư làm sạch riêng; chuẩn bị hộp vật sắc nhọn khi liên quan.

5.4. Trang thiết bị

Kiểm tra hoạt động, hiệu chuẩn và IFU đúng model; khử khuẩn bề mặt dùng chung giữa người bệnh, xử lý dụng cụ tiếp xúc giác mạc theo quy trình đã xác nhận. Phương tiện cấp cứu sẵn tiếp cận.

5.5. Người bệnh

Được giải thích về mục đích và các thì của thủ thuật.

Giải thích, xác nhận hợp tác/đồng ý theo mức can thiệp; đánh giá bệnh nền, thuốc, dị ứng và đúng mắt cần thực hiện.

5.6. Hồ sơ bệnh án

Theo quy định của Bộ y tế.

Có chỉ định, đánh giá và thông tin cần thiết của đúng người; giấy đồng ý và hồ sơ phẫu thuật khi áp dụng.

5.7. Thời gian thực hiện kỹ thuật

Thời gian thực hiện kỹ thuật: khoảng 20 – 30 phút.

Thời gian trong nguồn chỉ là ước tính, không phải thời gian bắt buộc chờ; ghi thực tế và theo dõi theo tình trạng.

5.8. Địa điểm thực hiện kỹ thuật

Địa điểm thực hiện kỹ thuật: phòng phẫu thuật.

5.9. Kiểm tra hồ sơ và người bệnh

Đối chiếu ít nhất hai định danh và đúng mắt/bên; kiểm tra chỉ định, nguy cơ, thuốc, dụng cụ, thiết bị, đồng ý và nhân lực. Dừng khi sai hoặc thiếu điều kiện, báo bác sĩ giải quyết.

6. TIẾN HÀNH QUY TRÌNH KỸ THUẬT

6.1. Bước 1

Kiểm tra trước gây tê/gây mê: đúng người, thủ thuật, mắt/bên, đồng ý, thuốc/dị ứng và thiết bị; kiểm đếm dụng cụ, kim, gạc ban đầu.

6.2. Bước 2

Vệ sinh tay ngoại khoa, trang phục/găng vô khuẩn; mở và bố trí dụng cụ theo các thì của đúng phẫu thuật. Thuốc trên bàn phải có nhãn và đối chiếu khi giao.

6.3. Bước 3

Tạm dừng trước rạch: cả ê-kíp xác nhận kế hoạch, bên mổ, nguy cơ, vô khuẩn và các yêu cầu đặc biệt.

6.4. Bước 4

Phụ mổ theo từng thì phẫu thuật do bác sĩ thực hiện: đưa dụng cụ, giữ trường, hỗ trợ hút/rửa và kiểm soát chảy máu theo yêu cầu; không tự thay kỹ thuật phẫu thuật.

6.5. Bước 5

Trước đóng/kết thúc: kiểm đếm lại; xác nhận thuốc, bệnh phẩm nếu có, băng và kế hoạch sau mổ. Khi thiếu dụng cụ/gạc phải báo ngay, thực hiện quy trình xử lý sai lệch.

6.6. Bước 6

Bàn giao sang theo dõi: phẫu thuật/mắt, phương pháp vô cảm, thuốc/liều, diễn biến, băng, y lệnh và dấu hiệu cần báo; ghi người nhận và thời điểm.

7. THEO DÕI VÀ XỬ TRÍ TAI BIẾN

7.1. Trong thực hiện

Chảy máu, đau bất thường hoặc tổn thương mắt: báo phẫu thuật viên, hỗ trợ xử trí và ghi diễn biến.

Khi sai người/mắt, phản ứng thuốc, đau dữ dội, tổn thương hoặc diễn biến toàn thân bất thường: dừng, bảo đảm an toàn, báo bác sĩ, đánh giá và xử trí theo tình trạng. Phản vệ xử trí ngay theo Thông tư 51/2017/TT-BYT; không trì hoãn cấp cứu để hoàn tất hồ sơ.

7.2. Sau thực hiện

Theo dõi đau, đỏ mắt, chảy máu và thị lực theo kỹ thuật. Giảm thị lực, đau tăng, sợ sáng hoặc khó chịu kéo dài cần bác sĩ khám. Không chỉ băng mắt hoặc tự cho thuốc để thay khám nguyên nhân. Thuốc và băng theo y lệnh.

7.3. Theo dõi muộn

Hướng dẫn không dụi mắt, dùng thuốc đúng đơn và tái khám theo chỉ định; quay lại ngay khi đau tăng, nhìn mờ hoặc triệu chứng xấu đi. Ghi và báo cáo sự cố, đánh giá lại trước thực hiện tiếp; không khẳng định tuyệt đối “không tai biến”.

Tài liệu tham khảo

QĐ3023/QĐ-BYT ngày 28/7/2023 về đề cương. Tài liệu nguồn QTKT DD năm 2025 do bệnh viện cung cấp. QĐ3517/QĐ-BYT ngày 12/11/2025 về Mắt Tập 1: cần đối chiếu đầy đủ đúng mục kỹ thuật trước ban hành. IFU và nhãn thuốc thực tế phải được xác nhận; các nguồn an toàn tại phần đầu hỗ trợ rà soát, không thay thế chỉ định chuyên khoa.

Danh mục chuẩn bị của kỹ thuật

TT	Danh mục chuẩn bị	Đơn vị	Số lượng
1	Lao động trực tiếp		
1.1	Điều dưỡng chuyên khoa Mắt	Người	01
2	Thuốc (tên hoạt chất, nồng độ, hàm lượng, đường dùng/dạng dùng)		Theo y lệnh / nhãn
2.1	Alcain 0.5%	Chai	Theo y lệnh / nhãn

TT	Danh mục chuẩn bị	Đơn vị	Số lượng
2.2	Natricorua 0,9%	Chai	01
2.3	Thuốc kháng sinh tra oflovid	Chai	Theo y lệnh / nhãn
2.4	Povidine 10%, povidine 5%	Chai	Theo y lệnh / nhãn
3	Vật tư (được sử dụng trực tiếp)		
3.1	Tâm bông vô trùng	Bịt	01
3.2	Gạc vô khuẩn	Miếng	01
3.3	Găng tay vô khuẩn	Cặp	01
4	Trang thiết bị (sử dụng trực tiếp)		
4.1	Sinh hiển vi	Cái	01
4.2	Bộ dụng cụ phẫu thuật quặm	Bộ	01

Danh mục kế thừa từ nguồn để đối chiếu, phải điều chỉnh đúng thiết bị và chỉ định; không thay thế các điều kiện mục 5. Thuốc/thiết bị có thông tin chưa xác nhận thì chưa sử dụng.

M-17. QUY TRÌNH KỸ THUẠT PHỤ MỔ SỤP MI

1. ĐẠI CƯƠNG

Hỗ trợ bác sĩ phẫu thuật sụp mi, duy trì vô khuẩn và an toàn người bệnh.

2. CHỈ ĐỊNH

Người bệnh sụp mi được bác sĩ xác định nguyên nhân và có chỉ định phẫu thuật; không dùng mọi biến dạng mi làm chỉ định mổ sụp mi.

3. CHỐNG CHỈ ĐỊNH

Nhiễm khuẩn tại mắt, bệnh toàn thân không cho phép.

4. THẬN TRỌNG

Xác định đúng người và mắt/bên; đánh giá dị ứng, thuốc và khả năng phối hợp. Đau tăng hoặc giảm thị lực cần bác sĩ đánh giá. Không để phép đo/thủ thuật trì hoãn cấp cứu; tránh ép nhãn cầu khi nghi vết thương hở. Trẻ em cần cách hỗ trợ và kế hoạch vô cảm phù hợp, không cố làm khi không an toàn.

Phụ mổ không thay thế quy trình phẫu thuật của bác sĩ; hoàn tất bảng kiểm an toàn phẫu thuật, kiểm đếm, quản lý thuốc, bệnh phẩm và bàn giao.

5. CHUẨN BỊ

5.1. Người thực hiện

Người thực hiện: Điều dưỡng chuyên khoa Mắt.

Theo phạm vi hành nghề, năng lực và phân công đã được xác nhận. Bác sĩ xác lập chỉ định; điều dưỡng chuẩn bị, hỗ trợ và theo dõi, chỉ trực tiếp thực hiện thao tác thuộc phạm vi được giao.

5.2. Thuốc

Thuốc Thuốc nhỏ tê Alcain 0.5%. Povidine 5% . Povidine 10% . Medicain 2% . Col. Vigamox 0,5% . Pd. Oflovid 0,3% . Dung dịch rửa mắt Natriclorid 0,9%

Dùng theo y lệnh và đúng nhãn chế phẩm; xác nhận dị ứng, nồng độ, liều, đường dùng, mắt và hạn dùng/hạn sau mở. Không áp dụng thuốc khi kỹ thuật không cần; không dùng chế phẩm sát khuẩn da thay dung dịch dùng cho mắt.

5.3. Vật tư

Thiết bị theo kế hoạch mổ và phương tiện cấp cứu; không sử dụng đèn cồn trong trường mổ.

2.2 Dụng cụ vô khuẩn: Găng vô trùng (02 đôi). Bơm tiêm 3ml, bơm tiêm 5ml, kim đầu tù (mỗi loại 01).Hộp gòn, gạc, tăm bông (đã hấp vô khuẩn) (01 hộp). Bình kiềm (01 cái). Cán dao số 15 (01 cái). Dao số 15(01 cái). Thanh đè mổ sụp mi (01 cái). Móc lác(01 cái). Kẹp kết mạc có mấu, không mấu (02 cái). Kẹp mang kim (01 cái). Kéo cong cắt chỉ (0 cái. Kéo kết mạc (01 cái). Bồ cào (02 cái) Chỉ Vicryl 5/0 (01 cái. Chỉ Silk 6/0(01 sợi). Khăn lỗ (01 cái)

Gạc/tăm bông và dụng cụ tiếp xúc vết thương phải phù hợp vô khuẩn; vệ sinh tay, găng/bảo hộ theo nguy cơ. Mỗi mắt có vật tư làm sạch riêng; chuẩn bị hộp vật sắc nhọn khi liên quan.

5.4. Trang thiết bị

Kiểm tra hoạt động, hiệu chuẩn và IFU đúng model; khử khuẩn bề mặt dùng chung giữa người bệnh, xử lý dụng cụ tiếp xúc giác mạc theo quy trình đã xác nhận. Phương tiện cấp cứu sẵn tiếp cận.

5.5. Người bệnh

Được giải thích về mục đích và các thì của thủ thuật.

Giải thích, xác nhận hợp tác/đồng ý theo mức can thiệp; đánh giá bệnh nền, thuốc, dị ứng và đúng mắt cần thực hiện.

5.6. Hồ sơ bệnh án

Theo quy định của Bộ y tế.

Có chỉ định, đánh giá và thông tin cần thiết của đúng người; giấy đồng ý và hồ sơ phẫu thuật khi áp dụng.

5.7. Thời gian thực hiện kỹ thuật

Thời gian thực hiện kỹ thuật: khoảng 20 – 30 phút.

Thời gian trong nguồn chỉ là ước tính, không phải thời gian bắt buộc chờ; ghi thực tế và theo dõi theo tình trạng.

5.8. Địa điểm thực hiện kỹ thuật

Địa điểm thực hiện kỹ thuật: phòng phẫu thuật.

5.9. Kiểm tra hồ sơ và người bệnh

Đối chiếu ít nhất hai định danh và đúng mắt/bên; kiểm tra chỉ định, nguy cơ, thuốc, dụng cụ, thiết bị, đồng ý và nhân lực. Dừng khi sai hoặc thiếu điều kiện, báo bác sĩ giải quyết.

6. TIẾN HÀNH QUY TRÌNH KỸ THUẬT

6.1. Bước 1

Kiểm tra trước gây tê/gây mê: đúng người, thủ thuật, mắt/bên, đồng ý, thuốc/dị ứng và thiết bị; kiểm đếm dụng cụ, kim, gạc ban đầu.

6.2. Bước 2

Vệ sinh tay ngoại khoa, trang phục/găng vô khuẩn; mở và bố trí dụng cụ theo các thì của đúng phẫu thuật. Thuốc trên bàn phải có nhãn và đối chiếu khi giao.

6.3. Bước 3

Tạm dừng trước rạch: cả ê-kíp xác nhận kế hoạch, bên mổ, nguy cơ, vô khuẩn và các yêu cầu đặc biệt.

6.4. Bước 4

Phụ mổ theo từng thì phẫu thuật do bác sĩ thực hiện: đưa dụng cụ, giữ trường, hỗ trợ hút/rửa và kiểm soát chảy máu theo yêu cầu; không tự thay kỹ thuật phẫu thuật.

6.5. Bước 5

Trước đóng/kết thúc: kiểm đếm lại; xác nhận thuốc, bệnh phẩm nếu có, băng và kế hoạch sau mổ. Khi thiếu dụng cụ/gạc phải báo ngay, thực hiện quy trình xử lý sai lệch.

6.6. Bước 6

Bàn giao sang theo dõi: phẫu thuật/mắt, phương pháp vô cảm, thuốc/liều, diễn biến, băng, y lệnh và dấu hiệu cần báo; ghi người nhận và thời điểm.

7. THEO DÕI VÀ XỬ TRÍ TAI BIẾN

7.1. Trong thực hiện

Báo phẫu thuật viên khi chảy máu, đau hoặc diễn biến bất thường; theo dõi khả năng nhắm mắt, bảo vệ giác mạc theo chỉ định.

Khi sai người/mắt, phản ứng thuốc, đau dữ dội, tổn thương hoặc diễn biến toàn thân bất thường: dừng, bảo đảm an toàn, báo bác sĩ, đánh giá và xử trí theo tình trạng. Phản vệ xử trí ngay theo Thông tư 51/2017/TT-BYT; không trì hoãn cấp cứu để hoàn tất hồ sơ.

7.2. Sau thực hiện

Theo dõi đau, đỏ mắt, chảy máu và thị lực theo kỹ thuật. Giảm thị lực, đau tăng, sợ sáng hoặc khó chịu kéo dài cần bác sĩ khám. Không chỉ băng mắt hoặc tự cho thuốc để thay khám nguyên nhân. Thuốc và băng theo y lệnh.

7.3. Theo dõi muộn

Hướng dẫn không dụi mắt, dùng thuốc đúng đơn và tái khám theo chỉ định; quay lại ngay khi đau tăng, nhìn mờ hoặc triệu chứng xấu đi. Ghi và báo cáo sự cố, đánh giá lại trước thực hiện tiếp; không khẳng định tuyệt đối “không tai biến”.

Tài liệu tham khảo

QĐ3023/QĐ-BYT ngày 28/7/2023 về đề cương. Tài liệu nguồn QTKT DD năm 2025 do bệnh viện cung cấp. QĐ3517/QĐ-BYT ngày 12/11/2025 về Mắt Tập 1: cần đối chiếu đầy đủ đúng mục kỹ thuật trước ban hành. IFU và nhãn thuốc thực tế phải được xác nhận; các nguồn an toàn tại phần đầu hỗ trợ rà soát, không thay thế chỉ định chuyên khoa.

Danh mục chuẩn bị của kỹ thuật

TT	Danh mục chuẩn bị	Đơn vị	Số lượng
1	Lao động trực tiếp		
1.1	Điều dưỡng chuyên khoa Mắt	Người	01

TT	Danh mục chuẩn bị	Đơn vị	Số lượng
2	Thuốc (tên hoạt chất, nồng độ, hàm lượng, đường dùng/dạng dùng)		Theo y lệnh / nhãn
2.1	Alcain 0.5%	Chai	Theo y lệnh / nhãn
2.2	Natricorua 0,9%	Chai	01
2.3	Thuốc kháng sinh tra oflovid	Chai	Theo y lệnh / nhãn
2.4	Povidine 10%, povidine 5%	Chai	Theo y lệnh / nhãn
3	Vật tư (được sử dụng trực tiếp)		
3.1	Tâm bông vô trùng	Bịt	01
3.2	Gạc vô khuẩn	Miếng	01
3.3	Găng tay vô khuẩn	Cặp	01
4	Trang thiết bị (sử dụng trực tiếp)		
4.1	Sinh hiển vi	Cái	01
4.2	Bộ dụng cụ phẫu thuật sụp mi	Bộ	01

Danh mục kế thừa từ nguồn để đối chiếu, phải điều chỉnh đúng thiết bị và chỉ định; không thay thế các điều kiện mục 5. Thuốc/thiết bị có thông tin chưa xác nhận thì chưa sử dụng.

Phiếu xác nhận trước ban hành

Đơn vị xác nhận: bộ phận Mắt và Phòng Điều dưỡng; phối hợp Dược, Kiểm soát nhiễm khuẩn và quản lý thiết bị theo nội dung.

Đối chiếu QĐ3517: mã/tên kỹ thuật và trang phụ lục tương ứng cho từng M-01–M-17: ……

Phạm vi kỹ thuật được phép, danh sách người đủ năng lực và nhiệm vụ điều dưỡng/bác sĩ: ……

Thuốc tê, giãn đồng tử, sát khuẩn: đúng chế phẩm, nhãn/đường dùng, liều cá thể và chống chỉ định: ……

Máy/model/IFU, khoảng cách bảng thị lực, cài đặt cao tần, quả cân/bảng Schiotz và quy trình khử khuẩn: ……

Đường gọi cấp cứu, kế hoạch xử trí mắt cấp, bàn giao và theo dõi sau can thiệp: ……

Người thẩm định/chữ ký/ngày; quyết định và hiệu lực: ……

Tóm tắt hiệu chỉnh: bỏ mục lục trùng; thêm thận trọng và chuẩn bị 5.1–5.9; sửa chống chỉ định tiếp nhận; làm rõ giới hạn phép đo và nhiệm vụ xâm lấn; bổ sung an toàn thuốc/mắt, xử lý dụng cụ, cài đặt theo máy; hoàn thiện các bước phụ mổ và bàn giao. Không xác nhận nhân sự trong ban biên soạn cũ là người ký bản mới; người bệnh viện thẩm định điền thông tin thực tế.